



CONTRAT DE GESTION

**ENTRE LE GOUVERNEMENT
WALLON ET L'AVIQ**

2024-2029

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Identification des parties

En application des articles 2/2 et 29 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'AVIQ exerce les missions qui lui sont confiées sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre

- d'une part le Gouvernement wallon, représenté par la Vice-Présidente du Gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de l'Égalité des chances et des Droits des Femmes, Madame Christie Morreale et la ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière en charge des allocations familiales, Madame Valérie De Bue,
- et d'autre part l'AVIQ, Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, représentée par la présidente du Conseil général, Madame Fabienne Winckel et l'administratrice générale, Madame Françoise Lannoy.

1.2. Cadre légal

Conformément au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ce contrat s'appuie sur :

- la réalisation d'une évaluation interne et d'une évaluation externe :
 - o l'auto-évaluation a été présentée en mars 2022 au Conseil général et aux Comités de branche ;
 - o l'évaluation externe par le consultant Impact Consulting a été présentée en juillet 2022.
- l'adoption par le Conseil général d'un projet de note d'orientation le 1^{er} septembre 2022 ;
- l'adoption le 21 décembre 2022 par le Gouvernement, sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale et de la Ministre en charge des Allocations familiales, d'une note d'orientation déterminant les lignes directrices du projet de contrat de gestion ;
- les avis motivés des comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 sur le projet de contrat :
 - o du 6 juin 2023 pour le comité de branche Santé ;
 - o du 6 juin 2023 pour le comité de branche Handicap ;
 - o du 6 juin 2023 pour le comité de branche Familles.

Le contrat s'inscrit pleinement dans les principes et obligations du décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information.

1.3. Durée, entrée en vigueur, adaptation et fin de contrat

Conformément au décret du 12 février 2004¹ relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information ainsi qu'au Code wallon de l'action sociale et de la santé,

- le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf révision anticipée du contrat de gestion décidée d'un commun accord entre les parties ;
- les parties peuvent proposer un avenant au contrat lorsque l'évolution des circonstances, les évolutions législatives ou encore l'octroi de missions nouvelles le justifient. Cet avenant devra être signé par les parties ;
- au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, les ministres de tutelle procèdent à l'évaluation prévue à l'article 4 du décret du 12 février 2004 précité ;
- si un nouveau contrat de gestion n'entre pas en vigueur à l'expiration du précédent, le contrat de gestion venu à expiration peut être prorogé par les ministres de tutelle pour une période non renouvelable de six mois. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

1.4. Contenu du contrat

« Le contrat de gestion précise les tâches que l'organisme assume en vue de l'exécution de ses missions de service public. Les objectifs d'impact, de qualité, d'efficacité, d'efficience et d'économie à atteindre, sont déterminés par des critères mesurables, précis et assortis de délais de réalisation ² ».

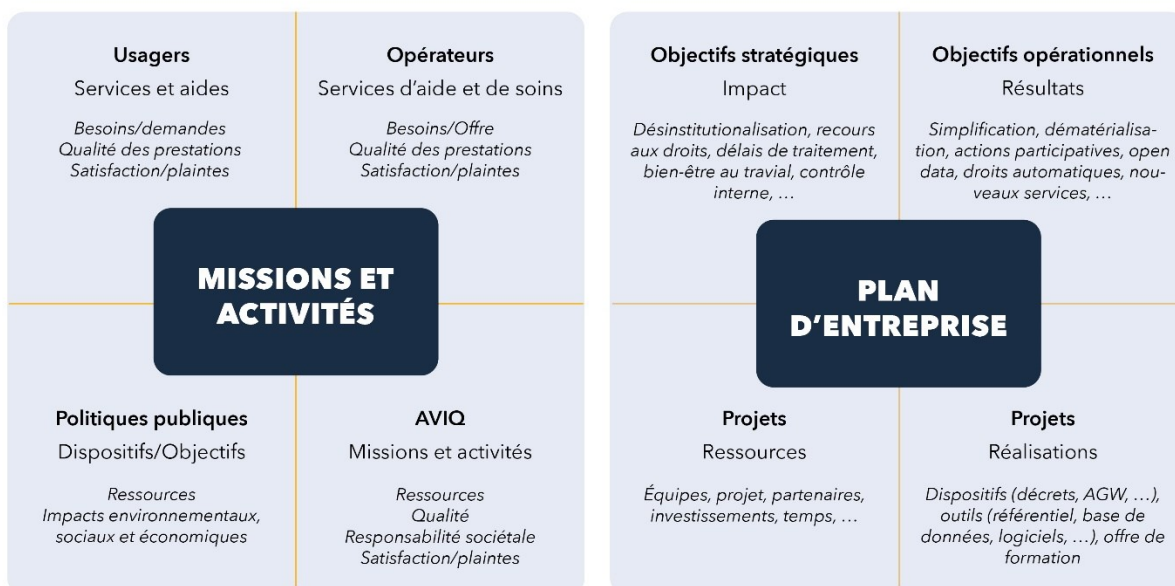
Il reprend :

- les **missions** et activités de l'Agence ;
- les **objectifs stratégiques et opérationnels** traduisant l'ambition, du Gouvernement et de l'Agence, d'un service public exemplaire, innovant, performant, mettant l'usager au centre de ses développements et priorités ;
- les **ressources humaines** de l'Agence et les modalités de gestion prévisionnelle et dynamique des effectifs et des compétences ;
- les **ressources financières**, particulièrement, la dotation régionale initiale nécessaire à la couverture des charges qui découlent de l'exécution du contrat de gestion, en tenant compte des coûts et recettes de l'Agence, les règles de mise à disposition, d'adaptation de cette dotation ;
- des **tableaux de bord** :

1 12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

2 12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, art. 9.

- reprenant l'ensemble des indicateurs relatifs aux besoins, à l'offre de services, aux missions et activités de l'Agence ainsi qu'aux politiques publiques ;
- reprenant les indicateurs d'impacts et de résultats en lien avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l'Agence ainsi que les ressources et réalisations consacrées aux projets et innovations du plan d'entreprise.



I.5. Suivi et évaluation

Conformément au Code wallon de l'action sociale et de la santé, dans les six mois de l'adoption du présent contrat, un Plan d'entreprise 2024-2029 sera présenté pour approbation au Conseil général. Ce plan comprendra, a minima, les moyens d'actions mentionnés dans le présent contrat. Ce Plan d'entreprise est révisable annuellement.

Dans ce même délai, les tableaux de bords seront finalisés, approuvés par le Conseil général et les comités de branche et transmis pour approbation aux ministres de tutelle.

Le Comité de direction présente un suivi de l'exécution du contrat de gestion au Conseil général selon le schéma suivant :

1. Évaluation à mi-parcours et en fin de contrat

Au départ des indicateurs d'impact, ces évaluations mesurent l'atteinte des objectifs stratégiques du contrat de gestion.

2. Mise en perspective annuelle

- a. au départ des indicateurs de **résultats**, mesurant le changement, les progrès engrangés au niveau des objectifs opérationnels ;
- b. le rapport d'activités de l'AVIQ mettant en évidence l'ensemble des statistiques relatives aux usagers, aux opérateurs, aux politiques

publiques ainsi qu'au fonctionnement de l'Agence (ressources humaines et budgétaires, qualité) ;

Ce suivi permet d'ajuster annuellement le plan d'entreprise et est transmis au Gouvernement.

3. Suivi des projets : rapport semestriel au Conseil général et aux comités de branche : analyse de l'évolution du semestre écoulé, en constatant et mesurant l'ensemble des **réalisations** et l'utilisation des ressources allouées aux projets.

1.6. Principes généraux de mise en œuvre du contrat

Le contrat de gestion de l'AVIQ traduit l'accord entre le Gouvernement et le Conseil général sur l'ensemble de leurs ambitions de service public, en termes de qualité et de maîtrise dans l'exercice de ses missions mais également en termes d'innovation et de changement.



Déclaration de politique régionale pour la Wallonie 2019-2024³

Le contrat de gestion est l'ensemblier et le levier des stratégies régionales que



Plan de relance de la Wallonie⁴

sont la Déclaration de politique régionale et l'ensemble des réformes qui en découlent, le plan de relance de la Wallonie (PRW), le Plan accessibilité 2022-2024 au bénéfice des personnes en situation de handicap, la Stratégie wallonne de parcours de vie intégrés pour les personnes en perte

d'autonomie, le Plan de promotion et de prévention de la santé Horizon 2030, les réflexions de cadrage de constats de l'accès à la santé et aux soins de santé du Collège central de stratégie et de prospective⁶,...

Il intègre également les leçons du passé : les évaluations internes et externes du contrat de gestion 2017-2022 ainsi que l'ensemble des recommandations du Parlement dans le cadre de la crise du COVID-19.



Parcours de vie intégrés des personnes en perte d'autonomie (désinstitutionalisation)⁵

³ www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf

⁴ www.wallonie.be/sites/default/files/2022-03/De%CC%81claration%20commune%20sur%20les%20priorite%CC%81s%20du%20Plan%20de%20relance%20wallon.pdf

⁵ www.aviq.be/sites/default/files/documents/2022-12/Rapport%20final%20-%20Strat%C3%A9gie%20wallonne%20pour%20des%20parcours%20de%20vie%20int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf

⁶ www.aviq.be/fr/actualites/reflexions-de-cadrage-de-constats-de-lacces-la-sante-et-aux-soins-de-sante



L'AVIQ exerce ses missions selon des règles spécifiques prises par ou en vertu du Code wallon de l'action sociale et de la santé et dans le cadre de la politique régionale décidée par le Gouvernement wallon mais aussi sous l'impulsion du Parlement.

En outre, l'AVIQ s'engage à mettre en œuvre ses missions en respectant les principes de service public suivants :

Égalité - L'AVIQ garantit à l'ensemble des usagers un accès au service public et une égalité de traitement.

Neutralité - Corollaire du principe d'égalité, l'impartialité des agents et l'interdiction de toute discrimination fondée sur les convictions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales ou tenant à l'origine sociale, au genre, à l'état de santé, au handicap ou à l'origine ethnique sont intrinsèques à l'esprit AVIQ.

Équité - L'AVIQ assure l'application des règles en tenant compte de la situation concrète de chacun.e afin de veiller à une égalité de droit, tenant compte des inégalités de fait.

Qualité - L'AVIQ assure une gestion des activités au meilleur rapport coût/qualité et recherche constamment à améliorer l'efficacité et la rapidité et la qualité du service aux usagers et aux partenaires.

Continuité - La continuité implique que tout service fonctionne de manière régulière et adaptée, prenant compte des besoins et des attentes des usagers et des partenaires mais également capable de répondre aux urgences et aux imprévus. L'AVIQ garantit, de plus, une présence physique des services sur l'ensemble du territoire wallon.

Adaptabilité - Attentive aux mutations sociales, économiques et environnementales, l'AVIQ veille à adapter ses services aux évolutions dans l'intérêt général.

Accessibilité - La simplicité des règles doit guider l'action de l'AVIQ, tournée vers les usagers et les partenaires. La simplification, la facilitation et la clarification des règles et procédures sont des leviers essentiels d'amélioration des services. Les services publics doivent aussi être accessibles en termes d'horaire, d'implantation géographique et d'accessibilité en transports en commun mais également en termes d'accessibilité aux outils digitaux.

Transparence - Les usagers et les partenaires disposent d'un droit à l'information sur l'action de l'AVIQ. La transparence est une condition du dialogue, de concertation et de contrôle de l'action des services publics par les usagers.

Fiabilité et confiance - La fiabilité des relations avec l'administration implique l'établissement de règles claires et stables. De plus, l'AVIQ se comporte en toutes circonstances en partenaire loyal.

CHAPITRE 2. MISSIONS DE L'AVIQ

2.1. Missions

L'AVIQ met en œuvre de manière efficace et efficiente, dans le cadre des moyens qui lui sont octroyés, conformément à l'article 2/2 du CWASS :

1° la **politique de santé**, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

2° la **politique familiale** visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, à l'exclusion des infrastructures d'accueil de la petite enfance et de leur financement ;

3° la **politique des personnes en situation de handicap**, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

4° la **politique du troisième âge**, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

5° les **prestations familiales** visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

L'Agence accomplit ses missions en étroite collaboration avec les administrations régionales, communautaires et fédérales.

Les valeurs de l'Agence qui guident son fonctionnement ainsi que le comportement de chaque collaborateur et collaboratrice au quotidien sont l'**équité**, la **solidarité** et la **qualité**.



Sa raison d'être est

**Le bien-être et l'autonomie pour
toutes et tous en Wallonie**

2.2. Fonctions et modes de gestion des instances

Cogestion des ressources de l'Agence

La gestion des ressources est assurée par le Conseil général sur la base des avis et propositions des Comités de branches.

Il s'agit d'un modèle de **cogestion** associant les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales, les partenaires sociaux interprofessionnels, les associations professionnelles, les représentants des usagers et l'autorité régionale à la gestion de l'Agence.

Par cogestion, est visé l'exercice en commun de la gestion et de l'administration de l'ensemble des compétences de l'AVIQ par les différentes parties prenantes qui composent les instances de l'AVIQ. La cogestion permet le partage de l'autorité et de la responsabilité de gestion

L'ensemble des parties prenantes, au côté du Gouvernement, s'impliquent dès lors dans la gestion financière et budgétaire, la gestion des ressources humaines, le pilotage et la supervision de l'exécution des missions de l'administration, nonobstant les délégations organisées par le CWASS, le Gouvernement ou encore le règlement d'ordre intérieur.

Les enjeux sont de permettre aux instances de déterminer les buts et objectifs de l'Agence, d'adopter et de superviser les plans d'action et d'allouer les ressources, laissant au comité de direction et à l'administration la gestion courante et opérationnelle de ses missions et activités.

Dans ce cadre, il est essentiel de mettre en place des dynamiques participatives et de co-construction des décisions, orientations et stratégies au sein des instances. Il importe également d'organiser un rapportage systématique des activités de l'administration ainsi qu'une parfaite transparence sur l'ensemble des actes qu'elle pose (sont visées ici notamment les décisions à portée individuelle).

D'un point de vue pratique, l'Agence doit :

- analyser et optimiser la délégation de la gestion journalière (✕)
- construire un outil de rapportage des décisions déléguées à l'attention de l'ensemble des instances et du Gouvernement (✕).

Stratégie et prospective

Le Conseil général détermine, en concertation avec le Gouvernement, les orientations politiques générales stratégiques et prospectives à court, moyen et long terme de l'Agence.

Dans ce cadre, ses travaux s'appuient sur les analyses et évaluations des politiques réalisées par les comités de branche.

L'enjeu est de permettre à l'Agence d'impliquer toutes les parties prenantes dans une réflexion collective et participative et d'agir de la sorte sur la définition des politiques à court, moyen et long terme.

En termes prospectifs, anticiper une réforme de l'Etat, rencontrer l'évolution des attentes et des besoins des usagers, identifier les risques, inscrire l'Agence dans une trajectoire budgétaire durable, renforcer la protection sociale, ... sont autant d'ouvrages à mettre sur le métier au plus vite. Développer une capacité prospective au sein de l'administration comme au sein des instances permettront d'appréhender les futurs et très certainement d'apporter de la créativité et de l'innovation. Il conviendra également, dans ce cadre, de développer des synergies avec le monde de la recherche et de la formation.

Il est nécessaire d'outiller les instances afin de leur permettre d'accomplir cette mission et de renforcer l'expertise et les moyens des services.

Singulièrement, dans le cadre de l'élaboration du budget annuel, l'enjeu est de permettre aux comités de branche et Conseil général de soumettre au Gouvernement des pistes de nouvelles politiques à mettre en œuvre.

D'un point de vue pratique, l'Agence doit :

- inventorier et prioriser les dispositifs à évaluer (✕)
- réaliser une cartographie des parties prenantes tenant compte des convergences et différences entre les politiques et dispositifs (✕)
- évaluer la mise en œuvre de la sixième réforme de l'état (✕)
- développer une méthodologie au sein des instances pour alimenter cette fonction (✕).

Mission consultative

Le Conseil général remet un avis, d'initiative ou à la demande, au Gouvernement sur tout avant-projet de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives aux compétences transversales de l'Agence.

Les Comités de branche remettent d'initiative ou à la demande, un avis sur tout avant-projet de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives.

- à la politique de la santé, à la politique familiale et à la politique du troisième âge pour le Comité Santé ;
- à la politique des personnes handicapées pour le Comité Handicap ;
- aux prestations familiales pour le Comité Familles.

L'enjeu pour le Conseil général sera de porter en son sein les thématiques transversales mais également, conformément à l'article 4/1 §4 du CWASS d'assurer la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l'Agence et d'arbitrer les conflits de compétences et les conflits d'intérêt entre les branches de l'Agence.

La fonction consultative est un élément clé de la prise de décision politique. Il est en effet essentiel que l'avis et l'expertise des parties prenantes soient entendus par le Gouvernement wallon.

Les enjeux pour l'AVIQ sont d'associer les parties prenantes de des instances de l'AVIQ, particulièrement les quatre bancs siégeant au sein du Conseil général, en vue de dégager des intérêts et propositions partagés et d'enrichir les propositions de l'autorité, des initiatives locales, de terrain. Soutenir les dynamiques participatives, c'est reconnaître les parties prenantes comme les principaux acteurs et moteurs de la protection sociale wallonne.



D'un point de vue pratique, l'Agence doit :

- assurer et valoriser les résultats et recommandations des études et recherches réalisées par le collège de stratégie et prospective relatifs à l'accessibilité à la santé
- adopter des règlements d'ordre intérieur garantissant la sérénité et l'efficacité des débats
- déployer l'expertise de l'administration en vue de préparer, analyser les projets qui seront soumis à la consultation

- réunir les parties prenantes notamment au sein de groupes de travail ad hoc
- construire les projets d'avis, tenir les délais, s'assurer de la cohérence interne (notamment entre les comités de branche et le conseil général)
- mettre en place un partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et le Conseil consultatif Wallon des Personnes en Situation de Handicap
- se doter d'un secrétariat renforcé afin d'apporter un support administratif et logistique aux équipes et aux membres des instances ainsi que d'une nouvelle plateforme d'échange et de gestion des instances (✕).

2.3. Mise en œuvre des politiques d'action sociale et de la protection sociale

Missions régaliennes

Il s'agit des fonctions assurées par l'AVIQ qui ne peuvent être déléguées aux opérateurs et intermédiaires de paiements (caisses et organismes assureurs). Sont visées essentiellement les activités liées à la reconnaissance et l'agrément d'opérateurs, à leur financement et au contrôle du respect des normes, à l'évaluation de la qualité des prestations délivrées aux usagers, et de la bonne utilisation des subventions publiques, du soutien à la gestion, la gestion des plaintes, de la gestion des crises, de l'évaluation et du pilotage des politiques publiques et des stratégies de protection sociale.

Ces missions sont supervisées par le Conseil général.

Missions paritaires

Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires intervient par l'intermédiaire d'un organisme assureur wallon ou d'une caisse d'allocation familiale. La gestion paritaire, c'est-à-dire la gestion des moyens dévolus aux missions paritaires s'exerce entre un nombre égal de représentants des prestataires concernés par le service et de représentants des organismes assureurs wallons au sein des commissions paritaires qui négocient et concluent des conventions et déterminent les besoins de financement.

Les comités de branche approuvent les conventions conclues au sein des commissions paritaires, chacun pour ce qui relève de leurs compétences.

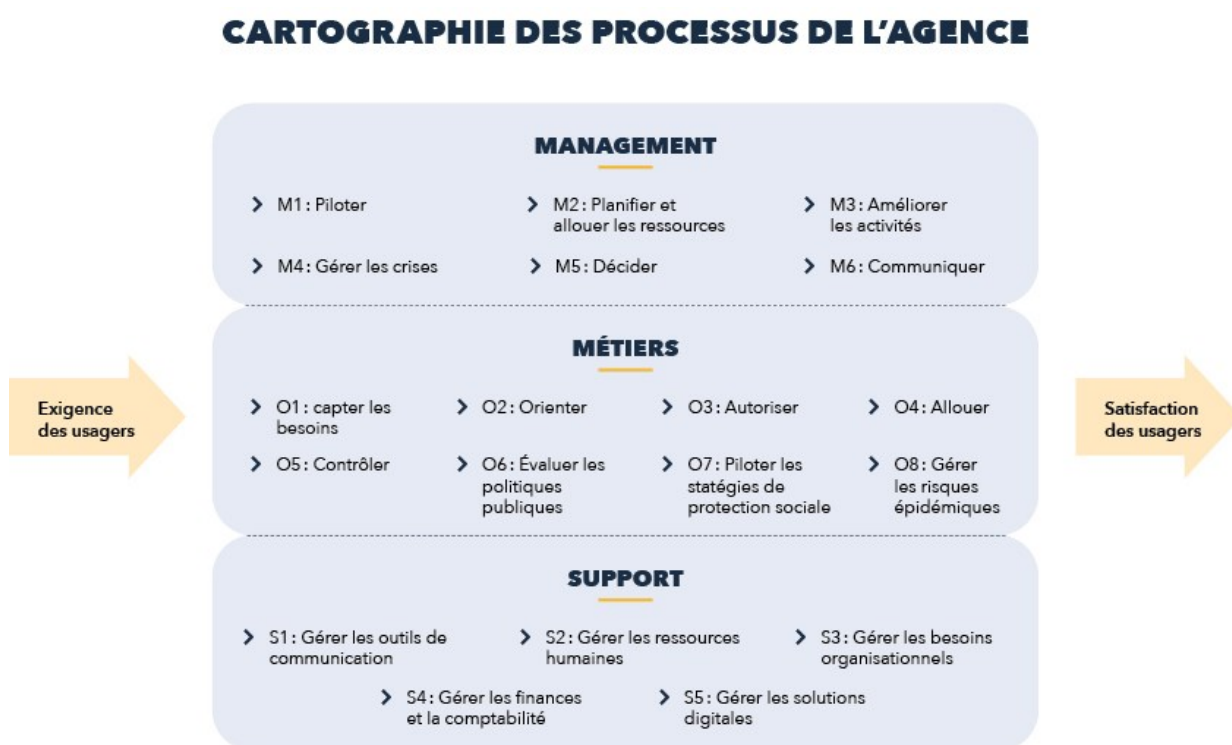
D'un point de vue pratique, l'Agence doit :

- Assurer un fonctionnement homogène de l'ensemble des commissions paritaires
- Mettre en place un calendrier anticipatif des travaux budgétaires (construction des nouvelles propositions de financement sous la forme de conventions) y compris dans les commissions qui actuellement n'abritent aucune convention
- Améliorer la documentation et l'information relatives aux propositions qui remontent aux comités de branche, notamment en termes de conséquences sur l'emploi et les travailleurs.

2.4. Processus et activités

L'Agence a réalisé un référentiel de ses activités.

Ces activités sont intégrées dans une cartographie des principaux processus de l'Agence offrant une vision globale du fonctionnement de l'Agence, depuis l'identification des besoins des parties prenantes (usagers, opérateurs, autorités, ...) jusqu'à leur satisfaction notamment sur la base des réalisations et des actions posées par l'ensemble des services de l'Agence.



2.4.1. Processus de management

M1 : Piloter : l'Agence pilote la mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels une fois qu'ils sont définis et répartis (contrat de gestion, tableau de bord (activités et projets), plan global de bien-être au travail, ...).

M2 : Planifier et allouer les ressources : l'Agence détermine de quelles ressources (personnes, logiciels, équipement, budget) elle a besoin pour mener à bien ses projets et ses activités puis les alloue pour obtenir la meilleure efficacité. Cette planification et l'allocation des ressources se retrouvent dans le plan d'entreprise, le plan de personnel, le plan de formation et l'ensemble des travaux budgétaires.

M3 : Améliorer les activités : organiser les actions de l'Agence dans le bon sens, mesurer, analyser chacune de ses performances, planifier les projets, anticiper et gérer les risques, supprimer les dysfonctionnements, ... pour qu'elle puisse croître, pour qu'elle puisse fonctionner et évoluer de manière optimale (contrôle interne et audit interne).

M4 : **Gérer** les crises : mettre en œuvre les moyens et ressources nécessaires pour se préparer à une crise, y faire face et en atténuer les conséquences.

Sur la base de l'évaluation de la gestion de la crise sanitaire mais également au regard des obligations légales de l'Agence, trois plans internes d'urgence sont en cours de rédaction afin de prévenir et gérer les principaux risques de crises internes ou externes (de sécurité, organisationnels, sanitaires, d'urgence sociale...).

M5 : **Décider** : négocier, concerter et choisir entre plusieurs actions possibles face à une problématique donnée concernant les orientations générales de l'Agence et engageant son avenir, ou permettant de résoudre un problème ou une situation.

Il est impératif d'outiller les instances de l'Agence et l'administration en vue d'assurer une bonne organisation des débats, le suivi des décisions et leur publicité.

M6 : **Communiquer** : informer et mobiliser les agents, les membres des instances de l'Agence et les parties prenantes de l'Agence (usagers, partenaires, autorités).

2.4.2. Processus métiers

O1 : **Capter** les besoins : procéder à une analyse détaillée de la demande et/ou des besoins de l'interlocuteur afin d'entamer des actions nécessaires pour répondre à sa situation, tenant compte des évolutions sociétales.

O2 : **Orienter** : prendre connaissance de la demande ou du besoin spécifique de l'interlocuteur pour le diriger vers la meilleure solution identifiée par le répondant afin de répondre à sa situation.

O3 : **Autoriser** : permettre (ou non) l'exercice d'une activité dans un lieu ou un cadre donné.

O4 : **Allouer** : octroyer des montants financiers, des primes, des subsides, des allocations, des avances, des indemnités...

O5 : **Contrôler** : tout examen, vérification, enquête et recueil d'information afin de vérifier le respect des dispositions légales ou réglementaires, le respect de l'utilisation des moyens financiers alloués, de vérifier le respect des normes, de gérer les plaintes et alertes formulées par des tiers à l'encontre de professionnels reconnus et soutenus par l'AVIQ, de veiller à la qualité des services aux usagers et à leur amélioration.

O6 : **Évaluer** les politiques publiques : analyser les résultats d'une intervention publique pour savoir si celle-ci a atteint les objectifs qui lui étaient assignés et évaluer la qualité des prestations délivrées aux usagers.

O7 : **Piloter** les stratégies de protection sociale : mettre en place des plans et des projets pour permettre aux usagers et aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux (vieillesse, maladie, invalidité, charges de famille, etc.)

O8 : **Gérer les risques épidémiques** : développer des connaissances et mettre en œuvre des mesures de prévention dont les protocoles sanitaires, la vaccination, le suivi de cas, ... afin de limiter toute propagation de maladie infectieuse.

2.4.3. Processus support

S1 : **Gérer les outils de communication** : élaborer les outils et support de communication, diffuser de l'information objective par tout média, faire la promotion des services, renseigner les usagers, gérer l'événementiel, ...

S2 : **Gérer les ressources humaines** : recruter, soutenir le développement de chaque agent, développer les compétences et connaissances, gérer les carrières, organiser le dialogue social,...

S3 : **Gérer les besoins organisationnels** : processus incluant la gestion des stocks, l'utilisation des consommables et fournitures, l'entretien du matériel, les biens mobiliers et immobiliers de l'Agence, ainsi que l'aménagement des postes de travail, salles de réunion, ...

S4 : **Gérer les finances et la comptabilité** : exécution et suivi du budget ainsi qu'achat de biens ou de services dans le cadre des marchés publics de fournitures, de services ou de travaux ainsi que le suivi du contentieux.

S5 : **Gérer les solutions digitales** : gérer les demandes et requêtes, analyser les besoins, les développements/paramétrisations informatiques, les déploiements et mises en production, la maintenance du matériel et des logiciels (maintenance évolutive et corrective) et le support à destination des utilisateurs.

CHAPITRE 3. LES RESSOURCES DE L'AVIQ

3.1. Ressources humaines

L'AVIQ est la résultante de transferts de services fédéraux, régionaux et communautaires :

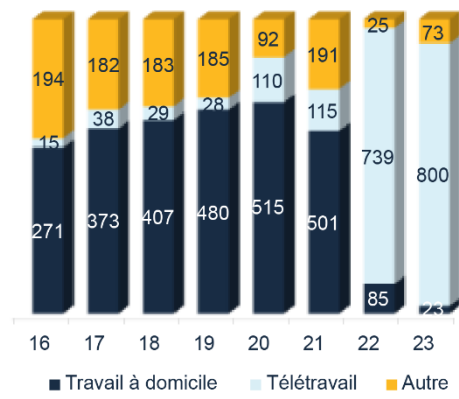
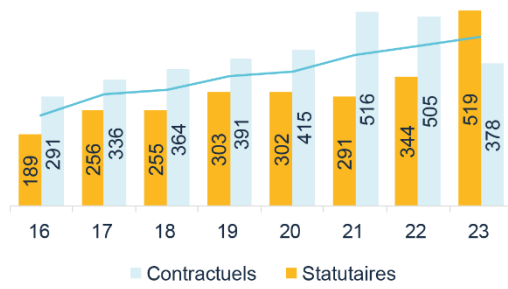
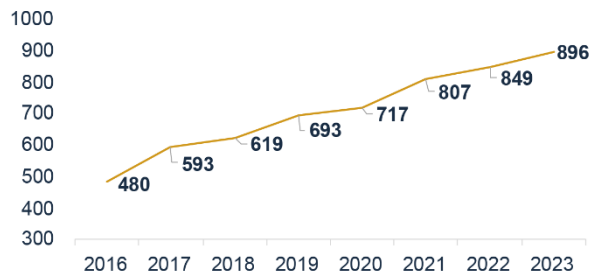
- 1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ;
- 2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale et la politique du troisième âge (SPW DGO5) ;
- 3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé ;
- 4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes ;
- 5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé ;
- 6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées ;
- 7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales.

Depuis sa création, l'Agence a ainsi intégré progressivement des politiques et des agents de différentes entités fédérales, régionales et communautaires :

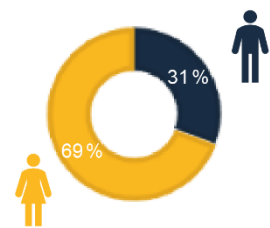
- Au 1^{er} janvier 2016 : toutes les matières handicap (AWIPH), les matières issues du SPF Santé publique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les matières gérées par le département de la santé du SPW - Pouvoirs locaux, Santé et Action sociale ;
- 2018 : des matières gérées par le SPF Sécurité sociale ;
- 2019 : des matières issues de l'INAMI et de Famifed ;
- 2021 : les allocations pour l'aide aux personnes âgées ;
- 2022 : les allocations familiales supplémentaires.

Les illustrations ci-dessous présentent quelques chiffres clés en termes de ressources humaines entre juin 2016 et juin 2023.

Parmi les évolutions marquantes, outre la croissance du nombre d'agents et d'ETP, on constate également une forte adhésion au télétravail (de 15 agents en 2016 à 800 agents au 1^{er} juin 2023 soit 89% du personnel) et un renversement en termes de statut, alors que les contractuels représentaient 60,6 % de l'ensemble des agents en 2016, l'Agence compte en juin 2023 57.9 % de statutaires. Enfin, la population est très majoritairement féminine et la répartition par sexe est stable (68-69 % sur toute la période).



3,57 %



Réforme du cadre

Conformément à l'article 11 du Code de la fonction publique wallonne, le cadre organique prévoit l'ensemble des postes d'encadrement de l'Agence, à savoir :

- Le directeur général A2, appelé administrateur général conformément au décret du 3 décembre 2015 constitutif de l'AVIQ et le directeur général adjoint A2, appelé administrateur général adjoint sur la même base ;
- Les inspecteurs généraux mandataires ou statutaires (dits experts) A3 à la tête d'un département ;
- Les directeurs A4/2 à la tête d'une direction ;
- Les premiers attachés A5 ;
- Les premiers gradués B1 ;
- Les premiers assistants C1 ;
- Les premiers adjoints D1.

L'AVIQ, depuis sa création le 1er janvier 2016, a connu 2 cadres organiques :

- le cadre organique partiel comprenant les postes d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, d'inspecteurs généraux et de directeurs, fixé par l'AGW du 9 mars 2017 ;
- le cadre organique complet comprenant les postes d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, d'inspecteurs généraux, de directeurs, de premiers attachés, de premiers gradués, de premiers assistants et de premiers adjoints, fixé par l'AGW du 10 décembre 2020.

La réforme du cadre adoptée par le Gouvernement ce 30 mars 2023 traduit principalement :

- la réforme du décret organique de l'Agence et particulièrement, la mise en œuvre future de la fonction consultative exercée par le Conseil général et les Comités de branche ainsi que la mise en place du Conseil consultatif wallon de la personne en situation de handicap ;
- la volonté de renforcer la transversalité et la collaboration entre les services. Jusqu'à présent largement organisée à travers les services support, la transversalité doit devenir l'affaire de tous. Chaque branche, chaque équipe au sein de l'Agence doit être consciente et actrice de cette transversalité tout en s'inscrivant définitivement dans une culture d'entreprise commune, apprenante, partageant les connaissances, les valeurs et les ambitions ;
- sur la base de l'évaluation de la gestion de la crise sanitaire et en réponse aux recommandations du parlement⁷, la nécessité de maîtriser les risques et gérer les crises, qu'elles soient internes à l'agence ou externes. Ainsi, la Direction de la surveillance des maladies infectieuses est créée et sera en charge de surveiller les risques sanitaires émergents et de pouvoir y répondre en cas de crise sanitaire ;

⁷ [359 1.pdf \(parlement-wallon.be\)](#).

- une gestion harmonisée des allocations individuelles, ainsi le département Familles gèrera, outre les prestations familiales, l'ensemble des allocations individuelles dont les allocations pour personnes âgées (APA) et les allocations familiales supplémentaires (AFS) ;
- une direction Audit et Inspection dans chaque branche, tout en conservant une philosophie et une méthodologie communes, qui visent non seulement le respect des normes mais aussi et surtout la qualité dans les services soutenus et agréés par l'Agence ;
- la création d'un département finances et juridique en vue de renforcer l'expertise et la maîtrise de la gestion budgétaire, comptable et des flux financiers de l'Agence d'une part, et d'autre part, d'appuyer l'ensemble des services dans leur politique d'achat, la gestion du contentieux et la simplification et l'harmonisation de la législation ;
- la création d'une direction de la gestion des biens mobiliers et immobiliers en vue de poursuivre nos efforts pour gérer nos infrastructures de manière durable et responsable et en adéquation avec la stratégie de travail hybride ;
- l'organisation de la mission consultative dont la coordination et le secrétariat sont logés au sein de la direction Partenariats et projets transversaux et internationaux du Département de la Stratégie et prospective en étroite collaboration avec les secrétariats et IG des trois branches de l'Agence ;
- le renforcement du pôle digital afin de répondre aux enjeux de la transformation digitale inclusive de l'Agence.

Sur cette base, le nouvel organigramme fonctionnel de l'Agence est le suivant :

Protection des données
Service interne de prévention et de protection
Audit interne et contrôle de gestion

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
F. Lannoy
Administratrice générale
A-F. Cannella
Administratrice générale adjointe

HANDICAP

A-G. Petit
Inspectrice générale ai

Emploi et participation
M. Goffelli
Directrice

Aide individuelle et autonomie
au domicile
J-M. Hautecler
Directeur

Accueil et hébergement
handicap
S. Ruquoy
Directrice

Audit et inspection handicap
S. Baude
Directeur

BUREAUX RÉGIONAUX

CHARLEROI
I. Maronnier, Directrice
DINANT
Libramont E. Gelon, Directrice
LIÈGE
J-M. Hurdebise, Directeur
MONS
P. Bridoux, Directrice
NAMUR - OTTIGNIES
E. Nellis, Directeur

SANTÉ

B. Bouton
Inspectrice générale

Promotion de la santé et
prévention
E. Delferrière
Directrice

Aide et soins ambulatoires de
première ligne
L. Mont
Directeur

Accueil et hébergement Santé
C. Buret
Directeur

Soins et infrastructures
hospitaliers
C. Charlet
Directrice

Surveillance des maladies
infectieuses
L. Sablon
Coordinateur

Audit et inspection Santé
V. Gousée
Directrice

FAMILLES

A-M. Wauthier
Inspectrice générale

Droits aux allocations
V. Michiels
Directrice

Audit et inspection
Familles
M. T'Sas
Directrice

Évaluation du droit aux
allocations spécifiques
M. Vandersanden
Coordinatrice

FINANCES ET JURIDIQUE
E. De Loecker
Inspectrice générale

Compatibilité et budget
O. Marcq
Directeur

Juridique et marchés publics
V. Cowez
Directrice

Financement
A. Van Gehuchten
Directrice

**COMMUNICATION,
PERSONNEL,
ORGANISATION**

N. Vanderniepen
Inspectrice générale

Information et communication
T. Dedonder
Directrice

Ressources humaines
N. Stalmans
Directeur

Gestion des biens mobiliers et
immobiliers
M. Walka
Directrice

Organisation et qualité
J. Rinchon
Coordinatrice

STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
M. Hanon
Inspecteur général

Évaluation et prospective
L. Poncin
Directrice

Partenariats et projets
transversaux et internationaux
A. Van WEYNENDAELE
Directeur

PÔLE DIGITAL

S. Oryn
Chief information officer

Infrastructures et support
F. Lorges
Directeur

Développement décisionnel
D. Claus
Coordinateur

Développement logiciel
En cours

Conception et analyse
V. Eggermont
Coordinatrice

Gestion prévisionnelle et dynamique des effectifs et des compétences (GPEC)

Entre 2020 et 2022, l'AVIQ a vu croître ses effectifs de 20 %. Cette augmentation est notamment liée à la nécessité de doter l'Agence de nouvelles compétences pour mettre en place un système permanent de prévention, de surveillance et de gestion des risques épidémiques.

Aujourd'hui et très probablement dans les prochaines années, l'AVIQ sera amenée à évoluer dans un environnement toujours plus volatile, incertain, complexe et ambigu (VUCA), avec une attention particulière sur l'utilisation des ressources financières disponibles, qui se doit d'être optimisée dans un contexte où les finances de la Wallonie ont été fortement impactées par les crises successives, les finances de la Wallonie étant fortement impactées par les crises successives (COVID, inondations, Ukraine, énergie, environnementale).

Dans ce contexte, l'Agence poursuit et intensifie la démarche de gestion prévisionnelle et dynamique des effectifs et des compétences.

L'objectif est d'adapter, - à court et moyen terme - les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la nouvelle vision stratégique et des modifications de l'environnement économique, technologique, social et juridique dans lequel l'Agence réalise ses activités.

Pour ce faire, l'Agence s'engage notamment à renforcer :

- sa gestion dynamique des effectifs et des compétences (✖)
- sa politique en matière d'intégration et de diversité
- le dialogue social
- sa politique de développement et valorisation des compétences (formation initiale et continuée, bilans et référentiels de compétences, etc.) (✖)
- l'internalisation de l'expertise
- sa politique de bien-être au travail, par l'adoption à court terme d'un plan global et des plans annuels de mise en œuvre (✖)
- la flexibilité et la mobilité en évaluant les modalités d'organisation du travail afin de rencontrer les attentes des agents et de l'administration (✖).

Le Gouvernement s'engage à :

- mettre à la disposition de l'AVIQ les moyens financiers qui lui permettront d'accomplir ses missions et d'atteindre les engagements au présent contrat, dans le respect de la trajectoire budgétaire définie par le Gouvernement
- pour les années 2023 à 2028, prévoir une indexation annuelle des dotations de fonctionnement sur la base des paramètres économiques définis par circulaire dans le cadre des processus d'élaboration budgétaire
- explorer avec l'ensemble des administrations régionales, les évolutions éventuelles du statut du personnel pour renforcer l'attractivité et l'engagement dans la durée des collaborateurs des services publics.

3.2. Ressources financières

Dépenses

Le budget de l'Agence représente plus de 25% des dépenses de la Wallonie en 2022. En 2024 le budget des dépenses était le suivant :

Dispositifs	Initial 2024	
Allocations familiales	2.916.127.000,00	41,89%
Allocations pour personnes âgées	156.071.000,00	2,24%
Infrastructures hospitalières	124.264.000,00	1,78%
Infrastructures aînés	26.063.000,00	0,37%
Infrastructures PH	12.320.000,00	0,18%
Infrastructures ETA	215.000,00	0,00%
Infrastructures autres	20.000,00	0,00%
Aînés - Services résidentiels et d'accueil de jour	1.523.167.000,00	21,88%
PH - Services résidentiels et d'accueil de jour	645.611.000,00	9,27%
Services d'aide aux familles	312.170.000,00	4,48%
Santé mentale	128.256.000,00	1,84%
Centres de revalidation fonctionnelle	108.614.000,00	1,56%
PH - Aide en milieu de vie	62.243.000,00	0,89%
Aides individuelles	64.216.000,00	0,92%
Première ligne de soins	51.988.000,00	0,75%
Promotion de la santé et Famille	25.086.000,00	0,36%
Assuétudes	8.262.000,00	0,12%
Subventions facultatives	7.213.000,00	0,10%
Maximum à facturer	0,00	0,00%
Entreprises de travail adapté	164.517.000,00	2,36%
PH - Aide à l'emploi ordinaire	48.176.000,00	0,69%
PH - Formation et d'insertion socio-professionnelle adaptée	8.500.000,00	0,12%
Frais d'administration - Caisses	39.654.000,00	0,57%
Frais d'administration - Organismes assureurs	25.229.000,00	0,36%
Frais d'administration - AVIQ	14.881.000,00	0,21%
Ressources humaines - AVIQ	89.731.000,00	1,29%
Hôpitaux	2.779.000,00	0,04%
Surveillance des maladies infectieuses	5.130.000,00	0,07%
Divers	391.153.000,00	5,62%
Dispositifs	6.961.656.000,00	100,00%

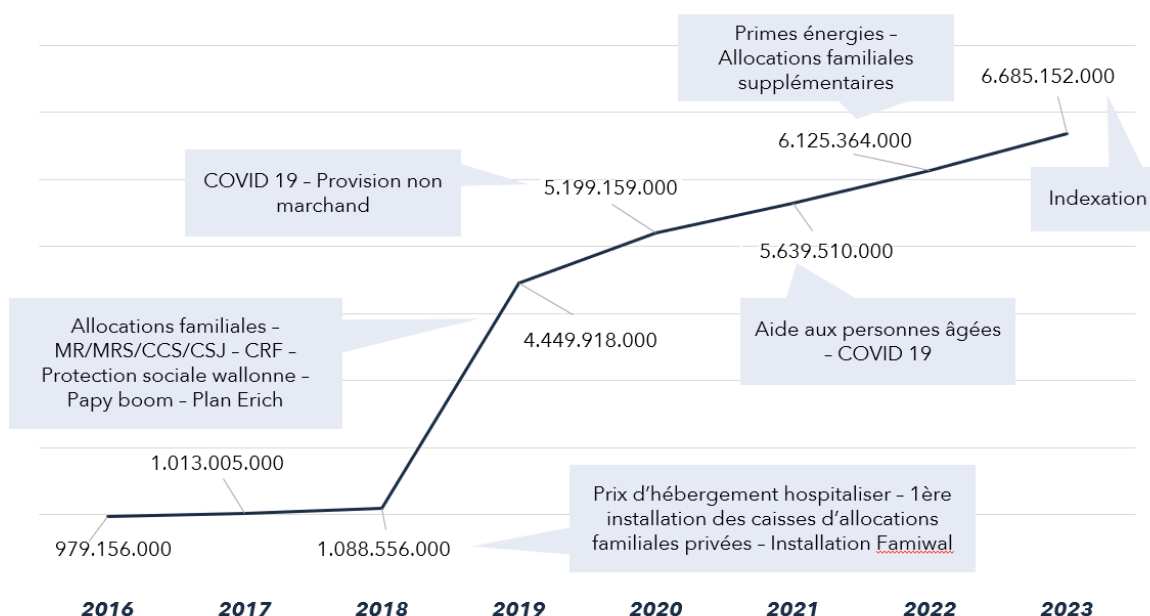
Le budget ajusté de l'Agence en crédits de liquidation a évolué entre 2016 et 2024 de la manière suivante :

	Crédits de liquidation ajustés	Evolution annuelle
2016	979.156.000	
2017	1.013.005.000	3,5%
2018	1.088.556.000	7,5%
2019	4.449.918.000	308,8%
2020	5.199.159.000	16,8%
2021	5.639.510.000	8,5%
2022	6.125.364.000	8,6%
2023	6.685.152.000	9,1%
2024	6.961.656.000	41%

Les principaux événements ayant exercé une influence sur l'augmentation des crédits sont présentés dans le graphique ci-dessous.

Il met en avant l'intégration progressive des dispositifs transférés à l'AVIQ mais également l'impact de la crise sanitaire et de l'inflation. Cette dernière ayant connu une accélération en 2022, l'inflation représente 714.536.000 euros entre le budget initial 2022 et le budget initial 2023.

Parmi les éléments ayant influencé l'augmentation des crédits, il convient d'évoquer l'Accord cadre du secteur non-marchand wallon 2021-2024 d'un montant total de 260 millions d'euros qui concerne en principal l'AVIQ dont la finalité est principalement l'engagement de personnel complémentaire et l'augmentation du salaire des professionnels du secteur « social et santé ».



Recettes

L'article 28 du CWASS énumère les ressources de l'Agence.

Les dotations en provenance de la Région ont progressé entre 2016 et 2023 de 5.353.988.000,00 EUR, soit +620,44%. Cette progression s'explique globalement par les mouvements suivants :

- 2019 : mise en place de la gestion des caisses d'allocations familiales par l'AVIQ.
- 2019 : intégration de la gestion du système de protection sociale wallonne dans le budget de l'AVIQ.
- 2021 : intégration du financement lié à la gestion de l'APA.
- 2023 : indexations.

Pour les budgets 2023 et 2024, les recettes sont réparties en programmes comme suit :

	Recettes 2023 (ajusté)		Recettes 2024 (initial)	
Dotation pour le fonctionnement de l'Agence	83.948.000	1,32%	92.112.000	1,41%
Dotations liées aux missions paritaires	4.485.118.000	70,73%	4.586.612.000	70,13%
Dotations liées aux missions réglementées	1.531.122.000	24,14%	1.628.486.000	24,90%
Dotations liées aux missions facultatives	97.552.000	1,54%	90.914.000	1,39%
Dotations liées aux missions des fonds structurels	1.565.000	0,02%	1.750.000	0,03%
Dotations liées aux missions dans le cadre du PRW	17.624.000	0,28%	0	0,00%
Recettes spécifiques à la gestion centrale de l'Agence	3.680.000	0,06%	4.520.000	0,07%
Recettes spécifiques à la branche Bien-être et Santé	8.535.000	0,13%	21.657.000	0,33%
Recettes spécifiques à la branche Personnes handicapées	70.041.000	1,10%	71.900.000	1,10%
Recettes diverses	-	0,00%		0,00%
Recettes spécifiques à la branche commune	42.401.000	0,67%	42.390.000	0,65%
Total général	6.341.586.000	100,00 %	6.540.341.000	100,00%

Trésorerie

Au 31/12/2022 le solde de trésorerie de l'Agence s'élevait à 921.691.547,97 **EUR**.

En termes de gestion budgétaire et financière, l'Agence s'engage notamment à :

- Respecter le calendrier budgétaire et ses échéances
- Améliorer le processus d'élaboration budgétaire en vue d'une meilleure participation des instances, une évaluation des besoins, la possibilité de soumettre des propositions d'innovations et de nouvelles politiques, la priorisation des demandes (✖)
- Elaborer une trajectoire budgétaire pluriannuelle (✖)
- Améliorer le monitoring budgétaire, financier et de trésorerie (✖)
- Appliquer une politique d'achat durable pour l'ensemble de ses marchés publics (clauses environnementales, sociales et éthiques) (✖)
- Veiller au transfert de connaissances, de données et d'informations acquis dans le cadre des marchés de services à l'Agence (propriété intellectuelle, des données, des codes, ...).

Le Gouvernement s'engage à :

- respecter le calendrier budgétaire et ses échéances
- mettre à la disposition de l'AVIQ les moyens financiers qui lui permettront d'accomplir ses missions et d'atteindre les engagements au présent contrat, dans le respect de la trajectoire budgétaire définie par le Gouvernement ;
- prévoir les montants nécessaires pour rencontrer le financement des investissements pour l'ensemble des implantations de l'Agence (en ce inclus, les investissements technologiques) et rencontrer les objectifs de transition écologique et énergétique à venir ;
- prévoir les montants nécessaires pour rencontrer le financement des investissements des opérateurs agréés fondés sur les plans pluriannuels approuvés par le Gouvernement dans le respect de la trajectoire budgétaire définie par le Gouvernement et rencontrer les objectifs de transition écologique et énergétique à venir ;
- faire évoluer et, le cas échéant, adapter les textes décrets et réglementaires en lien avec les politiques mises en œuvre en matière de santé, de handicap et de familles sur la base des orientations stratégiques approuvées par le Conseil général ;
- laisser à la disposition à l'AVIQ des gains d'efficience dégagés par l'activation de leviers, de projets afin de réinvestir dans la protection sociale wallonne (modèle à construire : pour mettre en œuvre cette disposition, il est nécessaire de développer un modèle qui détaille comment ces gains seront identifiés, évalués et réaffectés)).

Plus globalement, le Gouvernement s'engage

- à transmettre à l'AVIQ toute information, dans les délais utiles, dont disposeraient les Ministres de tutelle ou le Gouvernement wallon et qui serait nécessaire à la bonne exécution des missions de l'AVIQ ;

- au regard des défis et des axes stratégiques développés dans le présent contrat de gestion, à soutenir l'AVIQ dans ses démarches nécessaires à l'accomplissement de la vision du contrat de gestion ;
- à conclure et appliquer un protocole de collaboration avec l'Agence en vue de fluidifier et structurer les échanges et travaux (✕) ;
- d'informer l'AVIQ sur le suivi apporté à ses propositions et avis, notamment dans le cadre des propositions budgétaires.

CHAPITRE 4. ENJEUX

La crise sanitaire, les inondations et la crise énergétique ont exacerbé les urgences sociales. Elles ont mis en lumière les responsabilités et les attentes des citoyens à l'égard de l'Etat et des services publics. Il convient de tirer les leçons de ces douloureuses expériences afin d'armer au mieux l'Agence pour les affronter.

4.1. Lutter contre les inégalités - Favoriser l'accès aux droits

Les crises successives ont souvent renforcé les inégalités existantes en infligeant à certaines catégories de la population, au-delà de la crise elle-même, une double voire une triple peine⁸, les facteurs d'inégalités se révélant souvent cumulatifs et particulièrement impactant socialement.

On notera, sans être exhaustif :

- les inégalités se cumulent souvent ;
- la vulnérabilité différenciée face à la maladie et les différences de prise en charge ;
- les inégalités face aux mesures de prévention. On citera en exemple, dans le cadre des mesures de confinement, des inégalités dans le monde du travail (métiers dits essentiels qui n'ont pu être protégés de la même manière) ou encore des conditions de télétravail très disparates selon le lieu et le niveau de vie des personnes ;
 - Cela concerne en premier lieu le secteur de la santé et de l'action sociale, mais aussi ceux de l'industrie agroalimentaire, du commerce et de l'industrie. Lorsque leur activité était maintenue, la quasi-totalité des ouvriers et les trois quarts des employés ont été contraints de travailler en dehors de chez eux ; par contraste, c'était seulement le cas d'un tiers des cadres ;
 - Cette inégalité face au télétravail s'est souvent cumulée avec le fait de devoir se déplacer en transports en commun.
- les inégalités dans le recours aux soins ;
- les inégalités matérielles : certaines populations ont subi des baisses de revenus, d'activité, d'aides et d'activités informelles particulièrement importantes, associées à une hausse des dépenses, notamment alimentaires, seulement partiellement compensées par les aides publiques ;
- les inégalités de genre : majoritaires dans les métiers de la santé et du social, les femmes ont été en première ligne dans la réponse sanitaire apportée à la crise, ont eu à supporter une charge informelle plus élevée au sein des ménages, tout en étant plus exposées aux risques de violences conjugales ;

8 DOSSIERS DE LA DREES n° 62 • juillet 2020 Les inégalités sociales face à l'épidémie de Covid-19 État des lieux et perspectives Dossier coordonné par Claire-Lise Dubost, Catherine Pollak et Sylvie Rey (DREES)

- les inégalités liées à l'insuffisance de la prise en compte de la dimension du handicap dans les décisions, toutes compétences confondues, qui impactent leur vie.

Complémentairement, les expériences passées de quarantaine, mais aussi les premières leçons tirées du confinement pendant le Covid-19 décrivent des conséquences multiples à court et à long termes sur la santé mentale.

De nombreuses études invitent à porter une attention particulière aux conséquences pour les personnes isolées, âgées, en situation de handicap, les enfants et les adolescents et les personnes ayant des troubles psychiatriques préexistants, ainsi que pour les personnes dont les conditions de vie sont les plus précaires et se sont le plus dégradées.

Une identification des risques sur les personnes les plus fragiles pour disposer de plans d'action adaptés et une démarche proactive doit être menée dès le début d'une situation d'urgence, d'une catastrophe naturelle ou d'une pandémie, vivant dans des structures collectives mais également vers le domicile afin de préserver et renforcer leur autonomie à domicile ou dans les structures collectives.

Enfin les lieux de vie distinguent nettement les populations et leur situation face au coronavirus. Les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux (personnes âgées, personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie) cumulent un risque d'exposition élevé lié au lieu de vie et de dégradation de l'état de santé due à l'isolement.

Les personnes en situation de grande précarité, sans domicile, réfugiés et migrants notamment, cumulent une forte insécurité sanitaire, liée au risque d'exposition au virus dans des structures d'accueil collectives, des difficultés d'accès aux soins, ainsi qu'une forte insécurité économique accrue par l'absence de moyens de subsistance liée à l'interruption de leur activité par le confinement et l'absence d'allocations sociales.

L'AVIQ doit répondre au mieux à ces problématiques et apporter une réponse coordonnée et intégrée, en lien notamment avec les autres niveaux de pouvoir.

4.2. Vers une vision globale de la santé

L'Organisation Mondiale de la Santé décrit dès 1946, la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Toutefois, force est de constater que le partage des compétences entre les différents niveaux de pouvoir nécessite encore aujourd'hui des efforts accrus pour mener une politique globale et déterminer une vision partagée de la politique de la santé.

A titre d'exemple, le niveau fédéral exerce des compétences de prévention notamment pour ce qui relève des mesures prophylactiques, de la prévention dans la sphère du travail et surtout dans le cadre de la gestion, de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Au niveau francophone, la politique est partagée entre la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles (prévention dans les domaines de l'enfance et de l'enseignement).

Il y a lieu de mettre en perspective de manière permanente les articulations avec les autres compétences et niveaux de pouvoirs et d'enrichir les collaborations, via la transdisciplinarité, le travail en réseau, l'optimisation des trajets de soins, la prise en compte du parcours de vie global des usagers ainsi que la prise en compte des déterminants sociaux, économiques, culturels et environnementaux de la santé.

Cette articulation avec l'ensemble des compétences fédérales, régionales et communautaires se montre particulièrement indispensable face à la très grande précarité et aux processus qu'elle enclenche. Par exemple, la question du sans-abrisme renvoie aux problématiques plus vastes comme l'accès au logement, la précarisation accrue, la question migratoire mais également de problèmes sanitaires, psychiatriques, d'addictions, de handicap, d'emploi, de perte de droit, de rupture familiale, le décrochage scolaire...

Cette articulation permettra également d'allier les interventions individuelles vis-à-vis des usagers et de leurs familles aux interventions collectives et communautaires, pouvant ainsi se renforcer mutuellement.

4.3. Gestion des crises et anticipation des crises.

Les recommandations du Parlement wallon quant à la crise Covid font l'objet d'un suivi rigoureux au sein de l'AVIQ. Les analyses réalisées a posteriori de la phase aigüe de la crise vont dans le sens de la nécessité d'une plus grande préparation à ce type de situation.

Une culture de la prévention et de l'apprentissage à renforcer

L'ensemble des acteurs institutionnels, les scientifiques et les professionnels de la santé reconnaissent tous que nous n'étions pas suffisamment préparés pour faire face à de pareils événements. Si nos systèmes curatifs sont performants, nos systèmes préventifs méritaient une attention plus soutenue au sein de notre système de santé et ce à tous les niveaux de pouvoir.

Une coordination intersectorielle et multi-niveau à affirmer

La gestion de la crise, dans ses phases successives, a révélé les difficultés de communication et de coordination entre l'Etat fédéral, les entités fédérées (régions et communautés), les provinces et les communes.

La création de mécanismes extraconstitutionnels, comme le passage de la gestion du Centre National de crise vers le Comité de Concertation, la création des Commissariats Covid, ont amélioré la situation. L'absence de procédures spécifiques a nécessité de revoir, une fois la crise survenue, la chaîne de décision connue et la répartition des compétences tout en favorisant les efforts de coopération, de collaboration et l'implication de l'ensemble des parties prenantes.

Une étude de l'ODAS⁹ (Observatoire national de l'action sociale) qui a analysé les bonnes pratiques et initiatives inspirantes mises en œuvre par les collectivités locales et leurs partenaires pour répondre à des besoins identifiés dans le champ social pendant la crise sanitaire, a mis en évidence la puissance de la proximité lors des crises.

L'étude relève que ces initiatives locales sont caractérisées par la réactivité des acteurs face aux constats des besoins et leur capacité de s'adapter en allant notamment chercher dans leurs territoires, des ressources. Ce sont des illustrations d'une démarche « du bas vers le haut » où l'initiative émane d'acteurs ou d'institutions ancrés dans les territoires : initiatives individuelles, associations, bailleurs sociaux, collectivités locales, services et établissements de soins, services déconcentrés de l'Etat.

Ces initiatives ont permis à des professionnels de toutes compétences de sortir à certains moments de l'exercice très encadré de leurs métiers au profit d'une logique de mission. Il y a là un potentiel dans le développement de la capacité à agir des personnes qui pourrait être utilement pris en compte dans le management des organisations.

La crise sanitaire a mis en évidence la capacité des professionnels à agir selon leurs propres connaissances professionnelles afin de mener à bien leur travail en situation d'urgence.

Il est nécessaire de rechercher un équilibre entre la réglementation qui oriente l'action et l'espace nécessaire pour laisser l'initiative individuelle et collective prospérer localement. Il s'agit dans ce cadre de viser l'efficacité des services d'aide et de soins et rendre moins contraignantes la pratique quotidienne du travail dans le respect du dialogue social et la gestion des institutions.

La gestion des données

Quant à la gestion des données, on relèvera la focalisation sur le recueil de certaines données.

« Les membres des organes et instituts de santé publique soulignent leurs propres difficultés d'accès et de partage des données, qui sont cadencées par le Règlement général sur la protection des données, particulièrement strict sur les données de santé définies comme sensibles. La garantie de la confidentialité et la protection de l'anonymat des données participeraient à expliquer les délais de mise à disposition publique des données liées au Covid-19. Certain.e.s mettent également en cause le fonctionnement interne de certains organismes publics qui conditionnent la promotion des carrières professionnelles aux codes scientifiques de valorisation des publications. S'il importe de saluer le travail minutieux et conséquent de production de connaissances réalisé par les instituts et observatoires publics, il semble crucial

9 LA PUISSANCE DE LA PROXIMITE Crise sanitaire, bonnes pratiques et innovations Publication de l'Odas, avril 2022 Edition : Joachim Reynard Maquette

également de permettre la production et l'accès public et en temps réel des données de santé. »¹⁰

« La prise en considération des effets des inégalités sociales sur la diffusion, la contamination du Covid-19 et ses formes graves, enjoint à adopter une conception élargie de la santé, ce que fait et documente l'épidémiologie sociale, qui a demeuré fort absente du processus de consultation, de décision et de gestion de crise pour les raisons institutionnelles et organisationnelles expliquées en amont ».

La gouvernance des données est effectivement un enjeu pour toute organisation qui doit garantir la qualité de l'information (exactitude, actualité, intégrité, cohérence, exhaustivité, fiabilité, sécurité des données), la disponibilité des données, l'éthique dans l'utilisation et l'exploitation des données, la conformité de gestion des données et enfin, la sécurité des échanges et des entrepôts de données.

Face à cet enjeu, celui du maintien de la confiance de la population dans la gestion des données sociales et de santé et dès lors dans les politiques de santé qui en découleront, doit également être au centre des préoccupations de l'Agence.

L'Agence se doit d'améliorer sa collecte et sa gestion des données du droit des patients et du RGPD.

4.4. Le rôle des autorités publiques

Les crises ont profondément marqué les citoyens tant dans leur vie individuelle que collective mais également dans leur rapport aux autorités publiques conjuguant des attentes très importantes avec, pourtant, une crise de confiance certaine.

L'AVIQ se doit d'installer une relation de confiance avec les citoyens, les opérateurs, les partenaires institutionnels et les corps intermédiaires ainsi que ses collaborateurs.

Pour améliorer l'efficacité du dispositif actuel, il faudra créer les conditions de possibilité d'une meilleure coordination des acteurs, une meilleure définition des rôles de chacun, une harmonisation, une meilleure communication et une prise de décision à la fois globalisée et actualisée.

Complémentairement, afin de connecter au mieux les politiques aux différents niveaux de pouvoirs, une évaluation de l'intégration de la 6^{ème} réforme de l'état dans les pratiques comme dans les textes légaux est nécessaire ainsi que la mise en place d'une veille afin de suivre les réformes et initiatives des autres entités fédérées et fédérales impactant les politiques publiques relevant des missions de l'AVIQ.

Les autorités publiques se doivent également d'être le garant de la bonne utilisation des deniers publics par l'organisation d'un contrôle mesuré.

10 Apprendre de la gestion de la crise Covid-19 en Belgique pour penser une gestion plus collaborative et intégrée des prochains risques collectifs, op. cit.

4.5. Digitalisation de la société : vie privée, immédiateté, fracture numérique

Les crises successives ont amplifié la digitalisation de notre société sans pour autant en être à l'origine.

La digitalisation a permis des avancées importantes lors des crises. On pensera notamment aux possibilités offertes en matière de contact via les réseaux sociaux ou le développement des télé-conférences, les possibilités de télétravail, l'inscription à la vaccination à distance, les téléconsultations médicales, la diffusion des informations, ...

Elle soulève néanmoins de nombreuses questions quant à la protection de la vie privée, la propagation de fake news, les failles de sécurité des applications et autres appareils connectés, la déconnexion avec le monde réel, mais aussi et surtout les inégalités d'accès à ses nouvelles technologies.

L'agence numérique, dans son baromètre 2021 de maturité numérique des citoyens wallons¹¹, met en lumière que :

- 4% des ménages ne disposent d'aucun terminal ;
- 12% des personnes âgées de 75 ans et plus ne disposent pas de GSM ;
- 10% des ménages actifs avec enfants ont un équipement insuffisant pour le télétravail et les études de tous ;
- 12% disposent de connexion internet faible ou instable ;
- 17,9% de la population disposent de faibles connaissances ;
- 32% se sentent éloignés du numérique.

Tous ces chiffres montrent à souhait l'importance d'assurer un accompagnement des populations à la digitalisation et ce particulièrement dans le domaine de l'E-Santé tout en garantissant l'accès physique aux différents services d'intérêt public et une qualité d'accueil présentiel et relationnel.

4.6. E-Santé

« L'e-santé représente l'utilisation de l'informatique pour que l'aide et les soins au patient se déroulent de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. Pour pouvoir offrir aux patients la meilleure prise en charge, les patients eux-mêmes et leurs prestataires doivent avoir accès le plus rapidement possible à une information correcte. L'e-santé peut y contribuer. Grâce à internet, aux appareils mobiles, aux applis... les patients peuvent devenir les copilotes de leur propre santé. Et les prestataires d'aide et de soins tirent également profit de ces applications digitales : ils disposent toujours d'un dossier à jour de leurs patients, ils peuvent mieux communiquer avec leurs collègues et ils ont de nouvelles possibilités pour suivre leurs patients à distance. »¹²

11 BAROMÈTRE 2021 de maturité numérique des citoyens wallons, Agence du numérique, Digital wallonia.be

12 www.ehealth.fgov.be/fr/esante/lexique/lexique

Compétence partagée entre le Fédéral et les entités fédérées, l'e-santé constitue un enjeu majeur. En effet, le développement de notre système de santé ne pourra avoir lieu sans un développement massif et cohérent de l'e-santé.

Pour la Wallonie, la mise en place et le soutien d'un écosystème de santé numérique relatif au parcours de vie du citoyen permet de répondre à différents défis :

- Mettre ses propres données à la disposition de l'utilisateur ou du patient, quelle que soit sa situation, y compris en termes de vulnérabilités sociales ou en termes de handicap ou d'âge, en prenant également en compte la fracture numérique, et, in fine, favoriser l'autonomie par des choix éclairés, la littératie en santé et l'accessibilité aux prestations et services ;
- Eviter au citoyen de répéter sans cesse les mêmes informations le concernant, réduisant de la sorte la perte potentielle d'information pertinente pour un accompagnement de qualité ;
- Grâce à la numérisation des données d'aide et de soins, garantir aux prestataires de l'aide et des soins de pouvoir consacrer plus de temps à leurs usagers ou patients, en réduisant la charge administrative et en favorisant ainsi une augmentation qualitative des prises en charge ;
- Eviter la répétition d'examens inutiles et onéreux afin d'optimiser l'organisation de l'aide et des soins dans un contexte de pénurie de professionnels du secteur, grâce au partage de données ;
- Disposer d'un monitoring sanitaire global au niveau régional et de données de qualité afin de définir les objectifs de santé et produire des indicateurs visant à améliorer la qualité des services et des prestations ;
- Rationaliser les masses croissantes de données produites par les systèmes, tout en veillant à leur interopérabilité dans un cadre sécurisé et conforme au respect de la vie privée, le tout de manière éthique.

4.7. Les parcours de vie intégrés

Dans ses « Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique » du 28 octobre 2014 à propos de la mise en œuvre de la Convention de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU notait avec inquiétude que la Belgique avait un fort taux d'orientation des personnes handicapées vers des soins en établissement et qu'il n'y avait pas de plan pour la désinstitutionalisation. Il notait aussi qu'il n'y avait pas assez d'informations sur les possibilités de continuer à vivre au sein de la société et dans la communauté, les soins en établissement étant trop souvent considérés comme la seule solution durable. De plus, les personnes ont très peu de choix pour une autonomie de vie étant donné le manque d'investissement et l'insuffisance des services d'assistance personnelle.

Le Comité recommandait à la Belgique d'œuvrer pour une politique de désinstitutionalisation en réduisant les investissements dans l'infrastructure collective et en favorisant les choix personnels.

En ce qui concerne singulièrement la politique de désinstitutionalisation, il ne s'agit ni d'opter pour une extinction du modèle de prise en charge des personnes en perte d'autonomie dans les services d'accueil et d'hébergement ni pour la fermeture de services. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que ce modèle est né d'un combat militant,

le plus souvent de parents, pour assurer l'accompagnement, l'avenir et le bien-être de leur enfant et que le « modèle wallon » est régulièrement souligné pour sa qualité. Il doit certes évoluer et cette dynamique est d'ailleurs amorcée.

Une même mobilisation des personnes porteuses de handicap, de personnes souffrant de troubles de la santé mentale, de familles, de travailleurs sociaux et de la santé s'est développée au début des années 1980. Elle a permis le développement précurseur en Wallonie de services d'accompagnement en milieu de vie indépendants des structures institutionnelles d'accueil et d'hébergement.

Le 8 décembre 2021, le Conseil général de l'AVIQ adoptait une Stratégie de désinstitutionalisation intitulée « **Stratégie wallonne pour des parcours de vie intégrés des personnes en perte d'autonomie** » reposant sur 6 principes majeurs :

1. Sans confondre les publics en perte d'autonomie et la singularité de leurs besoins, des similitudes existent dans les politiques à mettre en place en matière de désinstitutionalisation ou de non-institutionnalisation des publics âgés, en situation de handicap et présentant des problématiques de santé mentale ;
2. La désinstitutionalisation n'équivaut pas à la fermeture pure et simple des institutions et l'accompagnement à domicile n'est qu'une option parmi d'autres. En effet, le domicile peut aussi représenter à certains égards une institution. Il est reconnu que certains publics souhaitent et ont besoin d'une institution. Pour cela, les aides existantes doivent être maintenues ;
3. La désinstitutionalisation est comprise en tant qu'évolution, adaptation et transformation des structures et des offres de services existantes afin de garantir le respect des droits des personnes et de permettre à toutes et tous de choisir leur lieu de vie ;
4. Il importe d'investiguer prioritairement les opportunités de renforcement (géographique, humain, financier, d'information et de communication, articulations possibles entre dispositifs, etc.), des dispositifs existants avant d'envisager la création de nouveaux. Garantir la lisibilité des dispositifs et éviter les effets « lasagne » ;
5. Il convient de réfléchir aux raisons qui mènent à l'institutionnalisation (dimensions économiques personnelles, d'isolement, d'épuisement des aidants proches, etc.) ;
6. La nécessité de valoriser les modèles d'inclusion et de participation des personnes basés sur le projet de vie : tubbemodelen, projets institutionnels construits avec la personne et les travailleurs et leurs représentants, humanitude, etc.

4.8. La territorialisation et la première ligne

S'agissant des soins de santé primaires, l'Organisation Mondiale de la Santé¹³ estime qu'ils

13 www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care#:~:text=Les%20soins%20de%20sant%C3%A9%20primaires%20garantissent%20que%20les%20personnes%20re%C3%A7oivent,possible%20de%20leur%20environnement%20quotidien

« garantissent que les personnes reçoivent des soins complets et de qualité, depuis la promotion et la prévention jusqu'au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs, au plus près possible de leur environnement quotidien. » De nombreuses études scientifiques partagent ce point de vue, à partir de l'analyse des organisations dans différents pays.

La Déclaration de politique régionale wallonne 2019-2024 se fonde notamment sur cette vision en précisant que :

« Plus globalement, une organisation territoriale de l'offre d'aide et de soins sera définie avec les acteurs de la santé à partir des zones de soins de première ligne réparties sur l'ensemble du territoire wallon... ».

En effet, le principal enjeu de la territorialisation est lié à l'accès, culturel, géographique et financier à la santé pour tous sur l'ensemble du territoire wallon.

Ce sont là les fondements de l'organisation de la territorialisation de la première ligne de soins et d'accompagnement.

Repenser l'organisation des services d'accompagnement et de soins en Wallonie implique une nouvelle organisation territoriale qui inclut la participation de l'ensemble des acteurs afin de construire un système efficient, coordonné et pérenne permettant l'inclusion et l'orientation efficace des citoyens au niveau local.

Cette nouvelle organisation devrait permettre

- un nouveau mode de gouvernance et de financement permettant une transparence accrue et un décloisonnement des secteurs,
- une réelle intégration, concertation et optimisation des projets sur le territoire de la Région wallonne, en tenant compte des spécificités locales, et de l'accompagnement et des soins au bénéfice du citoyen,
- un financement structuré des actions en santé (prévention et promotion de la santé, santé mentale, maladies chroniques, trajets de soins)
- une articulation entre les lignes de soins en particulier avec les institutions hospitalières, en créant un lien fort avec l'hôpital, les prestataires de soins et de services et les opérateurs sociaux
- une action contre la désertification des professionnels de la santé et de l'aide (attractivité et fidélisation)
- un cadre de travail de qualité et durable permettant une meilleure collaboration et une meilleure concertation entre les professionnels de la prévention, de la promotion de la santé, de l'accompagnement et des soins.

Elle devrait également permettre de répondre aux enjeux à plus long terme tant dans la prévention des maladies chroniques que l'orientation du citoyen vers le bon acteur de la prévention, de la promotion de la santé, de l'accompagnement et des soins tant local qu'en institution de soins, en assurant la lisibilité de l'écosystème et sa compréhension.

4.9. La transition énergétique et la décarbonisation

4.9.1. Décarboner l'administration publique

Transformer au quotidien l'administration publique pour diminuer son empreinte carbone est très certainement un enjeu des prochaines années afin de la rendre plus résiliente aux conséquences du changement climatique et de la raréfaction des énergies.

Dans ce cadre, les impératifs wallons en matière de gestion de l'énergie dans le secteur tertiaire reposent sur :

- La stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment actée par le Gouvernement wallon le 12 novembre 2020 : celle-ci s'inscrit dans la mise en œuvre de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Elle est un maillon clé des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans laquelle la Wallonie s'est engagée en visant « la neutralité carbone au plus tard en 2050, avec une étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % par rapport à 1990 d'ici 2030 ».
- L'obligation légale pour les institutions européennes et internationales, les autorités fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales d'afficher le certificat des Performances énergétiques de leurs bâtiments depuis le 1er janvier 2021.
- La circulaire du Gouvernement wallon visant à promouvoir la consommation énergétique responsable au sein de la Fonction publique wallonne (2022).

Le service public, en tant qu'employeur et consommateur au sein de la Wallonie, a un rôle majeur à jouer dans la transition, en étant à la fois exemplaire et innovant dans ses choix de mobilité (déplacement domicile-travail et professionnel), d'infrastructures (parc immobilier et organisation des espaces), d'usages numériques, d'énergie, de gestion des déchets, de commandes publiques.

L'enjeu¹⁴ pour une administration décarbonée est de :

- améliorer ses connaissances en matière de bilan carbone de l'ensemble de ses structures notamment par la délivrance de PEB pour l'ensemble de ses bâtiments et la mise en place d'un cadastre énergétique ;
- faire de cet objectif une priorité collective activant l'ensemble des leviers de l'organisation (finances, ressources humaines, IT, logistique, ...) ;
- passer d'une logique de communication ponctuelle à une logique d'intégration au quotidien des enjeux énergie-climat dans toutes les décisions relatives au fonctionnement et à l'organisation ;

14 ilnousfautunplan.fr/wp-content/uploads/2021/12/Decarboner-lAdministration-publique-Synthese-21-octobre-2021-1.pdf

- proposer des dispositifs de reconnaissance et de financement des opérateurs de protection sociale intégrant ces enjeux ;
- intégrer l'enjeu dans les stratégies à long terme de l'Agence (bâtiments, numérique, commandes publiques, ...) ;
- prendre en compte les aléas climatiques et énergétiques dans la gestion des risques et des crises ;
- former les agents et les décideurs afin de les mobiliser autour du sens des actions et réformes ;
- évaluer et communiquer sur les progrès accomplis.

Si les solutions semblent être évidentes ou tentantes en faveur de moins de bâtiments, plus de numériques, moins de déplacements, plus de télétravail, la stratégie de décarbonation doit préserver l'accès aux services publics, la continuité et les relations entre les services et les usagers et valoriser l'action sur le terrain et le travail de proximité et d'accompagnement des usagers.

4.9.2. Décarboner l'accompagnement et les soins aux personnes

Les opérateurs sont également confrontés aux enjeux climatiques et énergétiques et doivent également s'inscrire dans la stratégie de décarbonisation. Ils sont également et particulièrement en première ligne dans les crises climatiques et énergétiques et leurs impacts en termes de santé, de sécurité, de protection sociale.

L'enjeu est double : assurer un fonctionnement des services durable et résilient mais également attendre des secteurs qu'ils contribuent activement à la réduction des émissions et la transformation des pratiques parce que les secteurs de la santé et de l'aide aux personnes constituent un acteur économique majeur en Wallonie : pourvoyeurs d'emploi, investisseurs, consommateurs et donc, émetteurs de GES.

Dans ce cadre, il convient de

- renforcer la connaissance et la mesure des émissions des GES des structures en les soutenant dans la réalisation de leur bilan carbone ;
- placer la notion de sobriété au centre des pratiques d'accompagnement et de soins ;
- renforcer la prévention parce qu'elle limite les actes et prescriptions ;
- sensibiliser et former les acteurs aux enjeux climatiques et environnementaux ;
- développer et soutenir les politiques d'achats éco-responsables ;
- évaluer le coût des investissements, l'impact des normes environnementales sur ces investissements mais également les économies potentielles d'une transformation ;
- soutenir les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé comme ambassadeurs auprès des usagers, consommateurs du système de santé ;

« L'origine des maladies ne se trouve pas uniquement dans les gènes des individus ni exclusivement dans les virus ou microbes avec lesquels ceux-ci seront en interaction. Les maladies proviennent aussi de toutes les substances ou

phénomènes auxquels les personnes sont exposées dans leurs environnements, de manière répétée et avec plus ou moins d'intensité. »¹⁵

L'articulation des compétences et services en charge de la santé et de l'environnement est dès lors primordiale.

15 The Shift Project, *Décarboner la santé pour soigner durablement dans le cadre du plan de transformation de l'économie française*, Synthèse, Novembre 2021, p.6, theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/TSP_Sante%CC%81_Synthe%CC%80se_DEF.pdf

CHAPITRE 5. POUR UNE PROTECTION SOCIALE WALLONNE EFFICACE ET ACCESSIBLE



Une vision

Être le service public de référence, innovant et de confiance, à l'écoute des citoyen.ne.s et partenaires, acteur et garant d'une protection sociale wallonne efficace et accessible

Être une référence dans toutes nos missions pour l'ensemble des Wallons et Wallonnes, être innovante et créer des solutions pour les personnes qui s'adressent à nous. Être sensible et à l'écoute des besoins des citoyens et de l'ensemble de nos partenaires pour construire ensemble des solutions adaptées, intégrées et évolutives.

L'Agence se veut aussi être un acteur et non pas un spectateur dans la construction d'une protection sociale wallonne qui ne laisse personne au bord du chemin, qui automatise chaque fois que possible l'exercice des droits, être un service public accessible à toutes et tous quelles que soient les difficultés rencontrées.



Des valeurs

Équité - Solidarité - Qualité

Afin de réaliser cette ambition, le contrat de gestion de l'AVIQ s'articule autour de quatre axes stratégiques partagés par l'ensemble des parties prenantes.

Ces quatre axes constituent le cadre stratégique qui se veut dynamique par les connexions et interactions multiples entre eux.

Cette vision partagée s'est concrétisée et coconstruite au cours d'ateliers participatifs et a donné lieu à la rédaction d'un nombre limité d'objectifs

stratégiques et opérationnels eu égard aux recommandations des évaluations interne et externe.

Ce sont donc quatre objectifs stratégiques et dix-neuf objectifs opérationnels qui ont été retenus comme ossature et corps de ce nouveau contrat de gestion.

Incarner l'ESPRIT AVIQ
par l'expertise, la bienveillance,
l'engagement et l'auto-
gouvernance

- Renforcer la culture collaborative
- Développer les compétences
- Coconstruire un environnement de travail stimulant
- Améliorer le bien-être au travail
- Digitaliser et partager l'information

Grandir en tant qu'ORGANISATION apprenante et responsable

- Optimiser nos activités
- Anticiper et gérer les risques
- Évaluer les politiques publiques
- Piloter la transformation digitale inclusive



Accompagner chaque CITOYEN.NE
dans son quotidien, au départ de
ses besoins, ses aspirations, son
environnement

- Capter les besoins pour des réponses intégrées et adaptées
- Développer les compétences pour des choix éclairés
- Impliquer les citoyen.ne.s dans les projets qui impactent leur vie
- Automatiser le recours aux droits
- Bâtir une transformation digitale inclusive

Fédérer les PARTENAIRES pour
construire des réponses intégrées
et innovantes

- Simplifier les échanges administratifs
- Mobiliser les partenaires dans l'évaluation des politiques publiques et des réformes
- Centrer le cadre sur l'objectif commun, assoupli et permettant l'expérimentation
- Déployer les réseaux
- Digitaliser et partager

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS



AXE CITOYEN

Accompagner chaque citoyen.ne dans son quotidien, au départ de ses besoins, de ses aspirations et de son environnement

Assurer le bien-être et l'autonomie de chacun.e implique que l'Agence et ses partenaires soient sensibles et particulièrement attentifs aux situations de chacun.e et fournissent un accompagnement adapté, aux personnes qui le souhaitent, respectueux de leurs habitudes de vie, de leurs besoins, souhaits aspirations dans leur milieu de vie.

Le respect du choix des citoyen.ne.s est un objectif phare de la déclaration de politique régionale. Il constitue le fondement de tout système de santé et d'aide dans une démocratie. Il permet également de, sans cesse, se questionner quant à la volonté du citoyen tout au long de sa vie et d'ajuster les réponses aux besoins évolutifs. Un citoyen acteur de son bien-être dans les limites de sa volonté ou de ses capacités et non objet, tel est l'objectif de cet axe.

Cette approche doit évidemment avoir pour corollaire que l'AVIQ recherche les solutions toujours plus adaptées et plus efficaces en réponse aux besoins des citoyen.ne.s.

Dans cette perspective, les objectifs opérationnels suivants doivent être mis en œuvre :

Capter les besoins pour des réponses intégrées et adaptées

Les attentes et besoins évoluent sur la ligne de vie et selon les situations, il convient de mieux les appréhender pour assurer des réponses intégrées et adaptées. Il s'agit de fournir aux personnes les bons services aux bons moments et aux bons endroits. Pour ce faire, la collaboration avec les familles, les aidants proches, les experts du vécu, les professionnels, les opérateurs, les partenaires sociaux et les associations représentatives des usagers doit s'intensifier ces prochaines années.

Quelques projets illustratifs - (✕) :

- SWISS – Système wallon d'information socio-sanitaire (✕)
- Stratégie comportementale et culturelle (✕)
- Carnet de vie digitalisé – PRW 279 (✕)
- Outil d'évaluation de l'autonomie (✕)
- Plan d'accompagnement et de soins (✕)

Développer les compétences pour des choix éclairés

Bon nombre de citoyens, aujourd'hui encore, ne connaissent pas suffisamment leurs droits et les services et aides disponibles. Le succès des numéros verts et autres call centers mis en place à l'AVIQ en témoigne au quotidien. L'accessibilité de l'information constitue un enjeu prioritaire, particulièrement pour les publics fragilisés.

Ces informations sont indispensables aux personnes pour leur permettre de choisir en connaissance de cause et trouver des solutions adaptées à leur situation.

La mission confiée aux bureaux régionaux en cette matière par la déclaration de politique régionale sera à cet égard un enjeu majeur de la réalisation de cet objectif.

Néanmoins, il est important de maintenir et renforcer les différents points d'accès à l'information. Il n'est pas pertinent de prôner une porte d'entrée unique (guichet unique). L'enjeu est davantage de partager les expertises, les informations en travaillant tous ensemble (opérateurs de première ligne et services publics régionaux) à un accueil et un accompagnement transdisciplinaire et collaboratif.

La qualité des services et des prestations est une priorité. Dans ce cadre, l'Agence doit, au travers de ses services d'inspection et d'audit, garantir aux citoyen.ne.s le respect des réglementations et promouvoir la qualité. Complémentairement, les actions de formation et les partenariats en matière de qualité doivent être renforcés.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *ABC des démarches (✖)*
- *Chaque porte est la bonne : créer des réseaux d'accueil et d'information à partir des bureaux régionaux de l'AVIQ (✖)*
- *Peri-scope (publication des rapports d'inspection) (✖).*
- *Référentiels des ressources autour de chez soi (✖)*

Impliquer les citoyen.ne.s dans les projets qui impactent leur vie

L'implication des personnes dans les projets qui impactent leur vie est fondamental pour assurer la réussite de ces projets. Les citoyen.ne.s doivent être acteurs et moteurs de leur propre vie dans les limites de leur volonté et de leurs capacités, de leur autonomie et de leur bien-être et non un réceptacle ou un objet d'aide ou de soins.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Mesure de la satisfaction (✖)*
- *Plateforme participative citoyen.ne.s (✖)*

Automatiser le recours aux droits

Assurer l'exercice du droit se révèle parfois difficile : la complexité des démarches administratives, la distance physique et culturelle et les discriminations constituent des freins non négligeables. Lever tous ces obstacles est essentiel et ce, particulièrement, en simplifiant les démarches administratives à charge des usagers.

Dès lors, l'augmentation du recours aux droits passe immanquablement

- par la qualité de l'information sur les services et présentations fournis aux usagers, auxquelles les démarches de simplification et de lisibilité des démarches administratives y contribuent ;
- par l'accessibilité des services et des prestations : veiller à une bonne couverture géographique, des horaires, à la disponibilité des informations et formulaires dans une stratégie multicanale (web, guichet, courrier, call center, ...)
- par une démarche proactive des services afin d'identifier les ayants-droits et les accompagner dans leurs démarches ;
- par l'automatisation des droits dispensant un usager d'introduire une demande d'aide ou d'intervention dès lors que les critères d'accès à un autre droit lui ouvrent l'accès à cette aide automatiquement.

Quelques projets illustratifs- (✖) :

- *Cadastre des allocations familiales (✖)*
- *Non take-up streaming (méthodologie visant à repérer les non-recours) (✖)*
- *Plan Accessibilité*
- *Aide matérielle amplifiée (✖)*

Bâtir une transformation digitale inclusive

En sa qualité d'Agence de protection sociale wallonne, l'AVIQ se doit de construire sa transformation digitale en veillant à n'exclure personne par un accompagnement individuel mais aussi collectif et participatif. C'est pour cette raison, que lors de tout le processus de digitalisation, un Comité des utilisateurs sera mis en place pour tester les outils et s'assurer de leur pertinence et de leur accessibilité.

Une transformation inclusive ne peut être complète et adaptée que si elle s'accompagne humainement et physiquement pour toutes les personnes qui, quoi qu'on fasse et pour des raisons diverses, restent confrontées à l'exclusion numérique.

L'Agence devra également être attentive au respect du droit à ne pas recourir aux outils digitaux, le droit à ne pas savoir lire, le droit à ne pas savoir recourir aux capacités d'abstraction sans devenir pour autant dépendant d'un travailleur social qui devra servir d'interprète et qui deviendra par la force des choses, celle ou celui qui parlera « à la place de ... ».

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Dossier unique usager (only once) (✖)*
- *Comités des utilisateurs (✖)*
- *Aidants numériques (✖)*



AXE PARTENAIRE

Fédérer les partenaires pour construire des réponses intégrées et innovantes

Le transfert des compétences et les accords de la Sainte-Emilie ont fait de l'Agence un acteur incontournable de l'aide, du soutien et de la santé en Wallonie.

Forte de quelque 2.500 partenaires, l'AVIQ doit soutenir et déployer les services et aides sur l'ensemble du territoire, tout au long de la vie des usagers. L'AVIQ doit aussi promouvoir une meilleure articulation de l'offre et encourager l'innovation pour coconstruire des réponses adéquates, intégrées, adaptées, évolutives, de proximité et de qualité et sortir de la logique des tiroirs ou réponses standardisées et préformatées. Il s'agit aussi de valoriser les échanges de bonnes pratiques d'accompagnement des utilisateurs

L'Agence doit, pour ce faire, continuer à s'appuyer sur des partenariats avec les secteurs associatif et public, de manière à poursuivre le développement des politiques qu'elle a pour mission de mettre en œuvre et ceci de manière partagée avec les acteurs de la société civile.

Pour ce faire, il est impératif de :

Simplifier les échanges administratifs

L'écosystème de l'AVIQ s'est constitué au fil du temps, par l'adjonction successive de dispositifs. Ces dispositifs ont été transposés à l'identique pour assurer la continuité du service public.

Force est de constater, aujourd'hui, que bon nombre des démarches administratives imposées aux opérateurs pour chaque dispositif agréé se révèlent parfois redondantes, voire inutiles, ou différentes pour un même objet.

Il convient donc de revoir l'ensemble des transactions existantes entre l'AVIQ et les opérateurs tout en garantissant le contrôle quant à l'affectation des moyens publics et la bonne réalisation des missions d'intérêt public qui leur sont déléguées.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Principe de confiance (✖)*
- *Référentiel unique des opérateurs (MonAviq) (✖)*
- *Dématérialisation des démarches (MonAviq) (✖)*

Mobiliser les partenaires dans l'évaluation des politiques publiques et les projets de réforme

A l'instar de PROXISANTE ainsi que des travaux menés dans le cadre de la définition d'une Stratégie wallonne pour des parcours de vie intégrés des personnes en perte d'autonomie, il est impératif de mettre en place des mécanismes qui permettent d'associer les partenaires à la mise en œuvre des politiques du Gouvernement en ce compris dans leurs aspects évaluatifs.

Cette participation et cette adhésion constitueront un gage de réussite pour ces transformations indispensables.

La mobilisation des partenaires s'entend par la mobilisation des usagers, des opérateurs, des partenaires sociaux mais également des travailleurs et travailleuses de terrain.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Plateforme participative opérateurs (✖)*
- *Fonction consultative (✖)*

Centrer le cadre sur l'objectif commun, assoupli et permettant l'expérimentation

Faciliter, soutenir l'innovation et l'expérimentation de proximité doit permettre à l'Agence de s'adapter à la richesse et à la diversité des environnements dans lesquels les personnes évoluent mais aussi contribuer à coconstruire de nouvelles solutions en dehors des classiques tiroirs existants.

Conformément à la stratégie de parcours de vie intégré (désinstitutionalisation) et dans la droite ligne des recommandations des experts, l'AVIQ intègre dans les propositions de réforme ou de renforcement des dispositifs les objectifs suivants :

- Privilégier les pratiques inclusives
- Investir dans le développement des services dans la communauté
- Investir dans des infrastructures implantées dans un cadre ouvert, en petites unités, décentralisées, variées et multiples
- Donner la priorité à l'hébergement et l'accueil des adultes et enfants nécessitant un grand besoin d'accompagnement
- Promouvoir les services innovants
- Visibiliser les bonnes pratiques
- Renforcer les services de support à l'inclusion et l'assistance personnelle
- Investir dans le diagnostic précoce, la prévention et l'anticipation, en tenant compte des comportements et cultures

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Stratégie de revalidation fonctionnelle en Wallonie (✖)*
- *Continuum de soins de santé mentale (PRW275) (✖)*
- *Initiatives alternatives d'hébergement collectif (✖)*

- Révision des normes en MR/MRS dans une optique d'amélioration de la qualité (✖)
- Réforme de l'accueil et de l'hébergement - désinstitutionalisation (✖)
- Responsabilisation des intermédiaires de paiement (✖)

Déployer les réseaux

Souvent la construction de solutions adaptées aux besoins des personnes implique des réponses conjointes, combinées et coordonnées, voire intégrées, de plusieurs dispositifs (aides et services).

La constitution de réseaux locaux ou régionaux répond à ce besoin en associant sur un territoire donné des acteurs afin d'atteindre un objectif commun dans le respect de l'autonomie d'actions de chacun. L'organisation territoriale de l'accompagnement et des soins semble être la clé des systèmes qui fonctionnent adéquatement. La proximité permet une meilleure identification et rencontre des besoins, une meilleure organisation des offres, une meilleure évaluation et capacité d'adaptation.

L'articulation des politiques fédérales, régionales et communautaires est également indispensable dans une perspective de renforcements mutuels. L'AVIQ doit dès lors poursuivre ses partenariats particulièrement pour les publics à la croisée des secteurs.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

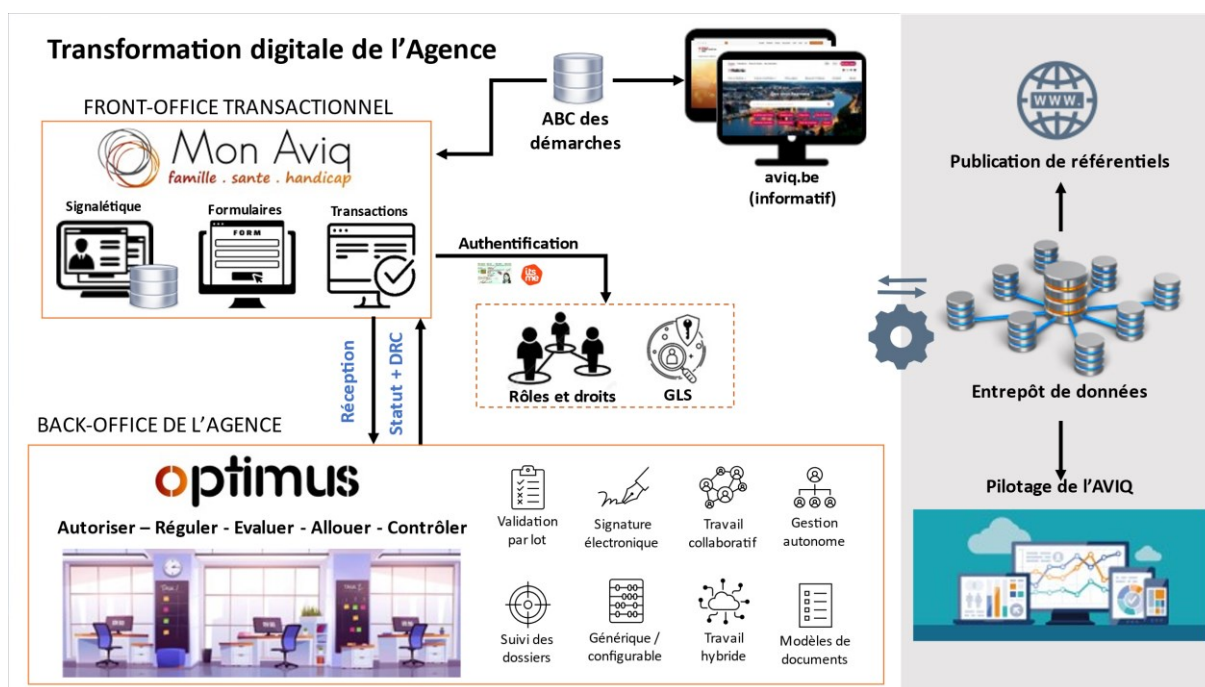
- Décret Proximité : PRW273 (✖)
- Case managers¹⁶ ou "coordinateurs intersectoriels" (✖)
- Chaque porte est la bonne (✖)

Digitaliser et partager l'information

La digitalisation et le partage d'information doivent permettre aux opérateurs de consacrer davantage de temps à leur métier premier et de disposer en temps réel des informations pertinentes pour réaliser les missions qui leur sont confiées.

Le parcours des demandes des opérateurs et des réponses apportées par l'AVIQ peut être schématisé comme suit :

16 En complémentarité avec le projet fédéral des soins intégrés.



Quelques projets illustratifs - (✖) :

- Mon Aviaq (front office transactionnel opérateurs) (✖)
- ABC des démarches (✖)
- W.all.in.health - PRW 281 (✖)



Dans un environnement changeant où la communication est immédiate, le service public doit être exemplaire en développant des approches préventives et en préparant l'avenir, en s'adaptant rapidement aux changements et en s'alliant aux partenaires institutionnels fédéraux, régionaux, communautaires et locaux afin d'assurer une action cohérente au service des Wallon.ne.s.

L'Agence doit être une organisation qui tire parti des expériences passées pour grandir, enrichir sa capacité organisationnelle et se monter responsable envers les citoyen.ne.s, les partenaires, le Gouvernement et le Parlement.

Il s'agit de développer sans cesse une culture généralisée d'amélioration continue de la performance.

Optimiser nos activités

Maîtriser l'ensemble des activités par une gestion efficace de l'organisation, évaluer et anticiper les risques, déployer le meilleur cadre de travail possible, mettre en œuvre des instruments de pilotage tels que des tableaux de bord de maîtrise de la performance (Usagers / Processus / Organisation apprenante / Finances) et de réalisation des objectifs sociétaux sont les ingrédients d'un service public moderne et d'une amélioration continue de la performance.

L'AVIQ doit évaluer ses activités et son fonctionnement en se questionnant sur sa responsabilité face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Rendre des comptes au Gouvernement, au Parlement et in fine aux citoyens en toute transparence relève des obligations d'un service public responsable.

L'AVIQ doit également évaluer son fonctionnement en se questionnant sur sa responsabilité et mesurer son impact sur les usagers, ses partenaires et son environnement afin de s'engager avec ambition face aux défis économiques, sociaux et environnementaux de la Wallonie. L'efficacité de l'action de l'AVIQ ne se mesure pas uniquement à l'aune de critères économiques, il est nécessaire d'établir des indicateurs d'évaluation qui participent à une dimension sociale et durable.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *OPTIQ (système de contrôle interne) (✖).*
- *Gestion dynamique des effectifs et des compétences (✖)*
- *Outils de monitoring des dépenses et des recettes (✖)*
- *Trajectoire budgétaire (✖)*
- *Tableaux de bord du contrat (✖)*
- *Délégation (✖)*

Anticiper et gérer les risques

L'Agence se doit de poursuivre la construction d'un dispositif de gestion des risques complet. Ce dispositif se doit de prévenir et d'assurer la gestion des risques tout en maintenant un niveau de stabilité de l'organisation elle-même.

Ce dispositif doit se fonder sur une identification permanente des risques possibles, un référentiel des activités critiques à maintenir et l'application et l'actualisation de scénarios d'intervention lors de l'apparition de crises, le tout piloté par une cellule de gestion de crise.

L'Agence doit également anticiper et participer activement aux réformes institutionnelles à venir.

Enfin, l'Agence doit contribuer dans ses disciplines à gérer les risques et les crises en articulant parfaitement son action avec les différents niveaux de pouvoirs (local, provincial, régional et fédéral) et les services partenaires (prestataires, partenaires, autres administrations).

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Plans internes d'urgence (✖)*
 - *Sécurité et santé (incendie, accident, fuite de gaz, ...)*
 - *Risques techniques (systèmes d'information et d'exploitation menacés)*
 - *Risques organisationnels (fraude, perte financière, conflit social, crise externe...)*
 - *Fermeture / crise au sein d'un service d'hébergement*
- *Gestion des risques épidémiques (✖)*

Évaluer les politiques publiques

On ne peut progresser et s'améliorer qu'en observant, analysant les impacts et les résultats des politiques mises en place.

Évaluer les politiques publiques met en lumière la relation entre une action publique et ses objectifs politiques. L'AVIQ réalise de nombreuses évaluations, celles-ci restent trop méconnues et sous-utilisées. Aussi, l'enjeu est de promouvoir cette pratique de l'évaluation, la structurer et accompagner tous les services de l'Agence ainsi que ses instances, à tous les stades de la mise en œuvre d'une politique (sa préparation, sa mise en œuvre, ses impacts finaux, ...). L'AVIQ doit renforcer sa fonction prospective. Pour ce faire, elle doit définir le cadre de l'exercice de cette activité et l'opérationnaliser en veillant à intégrer la dimension des inégalités sociales.

Elle doit également renforcer sa collaboration avec le monde de la recherche, de la formation et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Etude prospective sur les politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté infantile à l'horizon 2050 (✖)*
- *Évaluation des politiques publiques*
 - *Inventaire et priorisation des dispositifs et objectifs politiques (✖)*
 - *Cartographie des parties prenantes (✖)*
 - *Études (empiriques et spécifiques) de santé publique visant la mise en exergue des déterminants sociaux de santé et les facteurs de mauvaise santé (@)*

Piloter la transformation digitale inclusive de l'agence

Le projet de transformation digitale inclusive de l'Agence est large et varié et ne se limite pas à des aspects purement technologiques. Il vise au contraire à modifier, à accompagner, en n'oubliant personne dans ce processus de digitalisation.

Les enjeux de la transformation digitale inclusive de l'AVIQ sont multiples :

1. Assurer l'environnement et les conditions de travail optimaux ;
2. Être en phase avec les attentes des usagers (citoyen.ne.s et partenaires) ;
3. Déployer une démarche participative ;

4. Soutenir l'innovation en interne et au sein de son écosystème (particulièrement en matière de politique de santé et d'inclusion) ;
5. Améliorer la collaboration entre les équipes ;
6. Optimiser ses processus et son offre de services ;
7. Affiner la maîtrise des coûts ;
8. Simplifier et automatiser les tâches les plus répétitives ;
9. Améliorer l'exploitation des données et des connaissances ;
10. Assurer la qualité, la sécurité et la confidentialité des données ;
11. Être plus agile, capable de se réorienter, de se remettre en question, de rebondir, ... ;
12. Innover pour assurer et préparer l'avenir (nouvelles réformes institutionnelles) ;
13. Développer la visibilité et la notoriété de l'Agence ainsi que rendre l'organisation et les activités lisibles.

Pour ce faire, un pilotage rigoureux et suivi sera mis en place via un comité de pilotage réunissant les référents des différents axes du présent Contrat de gestion et les Chefs de programmes et de projets. Ce pilotage fera l'objet d'un suivi au sein des instances de l'Agence (Conseil général et Comités de branche) afin de garantir que la démarche est inclusive et de s'assurer du bon déroulement des opérations, de la pertinence des projets par l'évaluation de ceux-ci. Il sera épaulé par un Comité des usagers chargé de tester les outils et s'assurer de leur pertinence et de leur accessibilité.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Feuille de route de la transformation digitale inclusive (✖)*
- *Feuille de route cybersécurité (✖)*
- *Gouvernance des données (✖)*



AXE ESPRIT AVIQ

Incarnar l'esprit AVIQ par l'expertise, la bienveillance, l'engagement et l'auto-gouvernance

L'AVIQ compte aujourd'hui près de 900 collaborateurs. Elle doit mobiliser tout ce potentiel humain, cette expertise et cet engagement par un management bienveillant et la mise en place du principe d'autogouvernance qui vise à clarifier les responsabilités et les règles de fonctionnement et à développer des formes d'autonomies et de leaderships, flexibles, agiles, évolutives, adaptées aux environnements complexes et mouvants...

Pour ce faire, il conviendra de :

Renforcer la culture collaborative

L'Agence doit mobiliser ses collaborateurs pour coconstruire une culture collaborative orientée vers la résolution de problèmes et la recherche de la performance et de l'efficacité.

Dans ce cadre, il est indispensable de réaffirmer l'importance de la concertation sociale interne, considérant que l'esprit AVIQ est aussi marqué par la volonté de faire vivre le dialogue social avec les représentants des travailleurs et de respecter les organes paritaires de concertation.

Quelques projets illustratifs- (✖) :

- *Nouveau cadre organique (✖)*
- *Communautés de pratiques (✖)*
- *Espaces de travail partagés (✖)*

Développer les compétences

L'AVIQ doit veiller à être attractive pour l'ensemble des postes à pourvoir tant par leur valorisation pécuniaire que par les conditions de travail proposées. Elle doit être ouverte à tous et être un modèle en termes de diversité, d'inclusion du personnel en situation de handicap ou de santé, d'égalité hommes-femmes.

Les compétences et expériences doivent être reconnues et valorisées. Réunir en son sein des agents issus d'administrations fédérales, communautaires et régionales est une richesse. Il faut promouvoir l'intelligence collective pour avancer dans la complexité, innover et évoluer.

L'épanouissement de chacun doit être recherché par un accueil et un accompagnement de chaque collaborateur, des opportunités de mobilité interne et la possibilité de se former tout au long de sa carrière.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Stratégie de formation (✖)*
- *Valorisation et certification des compétences et expériences (✖)*
- *Branding (✖)*

Coconstruire un environnement de travail stimulant

L'Agence, pour assurer au mieux l'exercice de ses missions, doit mettre à disposition de l'ensemble de ses collaborateurs un environnement de travail sain, sécurisant et stimulant et ce, dans le respect d'un dialogue social constructif.

Quelques projets illustratifs - (✖) :

- *Stratégie immobilière AVIQ (✖)*
- *Feuille de route « Objectifs de développement durable » (✖)*
- *Stratégie de travail hybride (✖)*

Améliorer le bien-être au travail

Au travers de cet objectif opérationnel, l'AVIQ développera un plan pluriannuel de bien-être au travail qui intégrera tant les recommandations du Service interne de prévention et de protection au travail que les recommandations issues des rapports d'analyse des risques de psycho-sociaux et les recommandations en matière de prévention et de promotion de la santé.

Ce plan sera élaboré de façon participative ; il sera décliné annuellement en actions prioritaires.

Projets - (✖)

- *Plan Global et Plans Annuels de Bien-être au travail (✖)*
- *Accompagnement au changement (✖)*
- *Plan AVIQ en pleine santé (✖)*
- *Droit à la déconnexion (✖)*

Digitaliser et partager l'information

La transformation digitale doit permettre un mode de fonctionnement collaboratif, transverse et agile, où l'information circule de manière fluide entre les collaborateurs et services. Cette transformation doit donc se faire en mode agile et itératif centré sur l'utilisateur (les collaborateurs ici).

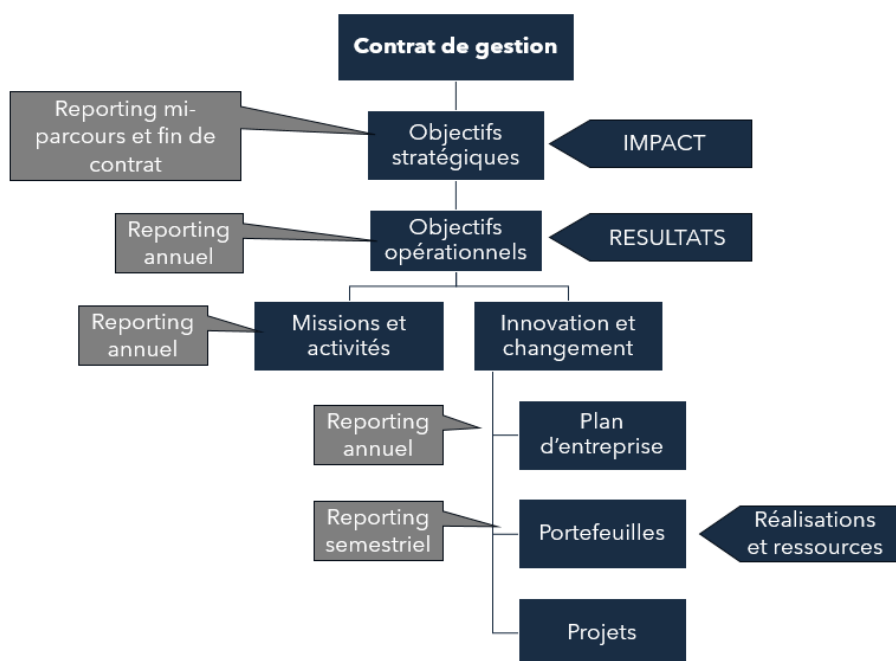
Le travail hybride fait partie intégrante de cette révolution digitale, en permettant d'améliorer le cadre et les modalités de travail pour une meilleure qualité de vie des agents et de répondre à leurs aspirations.

Quelques projets illustratifs- (✖)

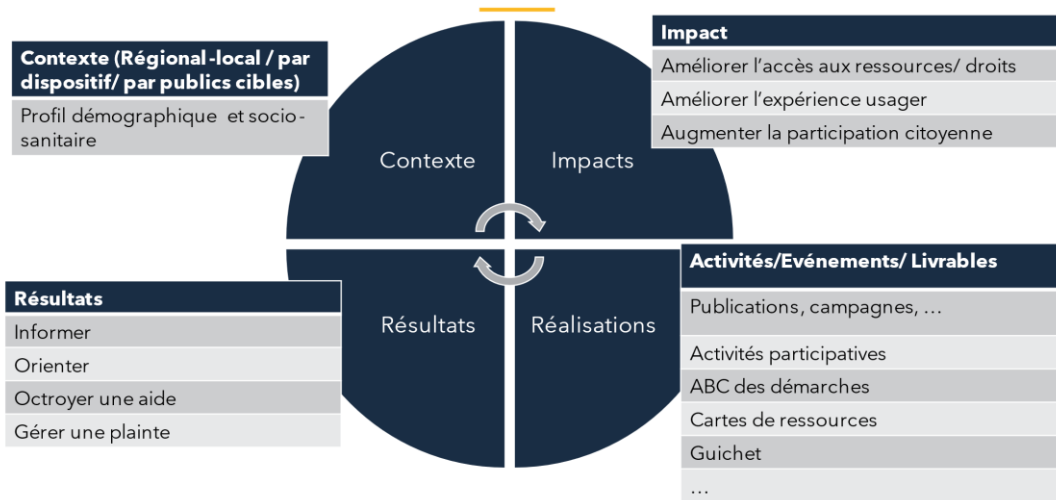
- *Plateforme participative (✖)*
- *Référentiel des ressources AVIQ - Qui fait quoi ? (✖)*
- *OPTIMUS (back office de l'Agence) (✖)*
- *E-délibération (✖)*

CHAPITRE 6. INDICATEURS

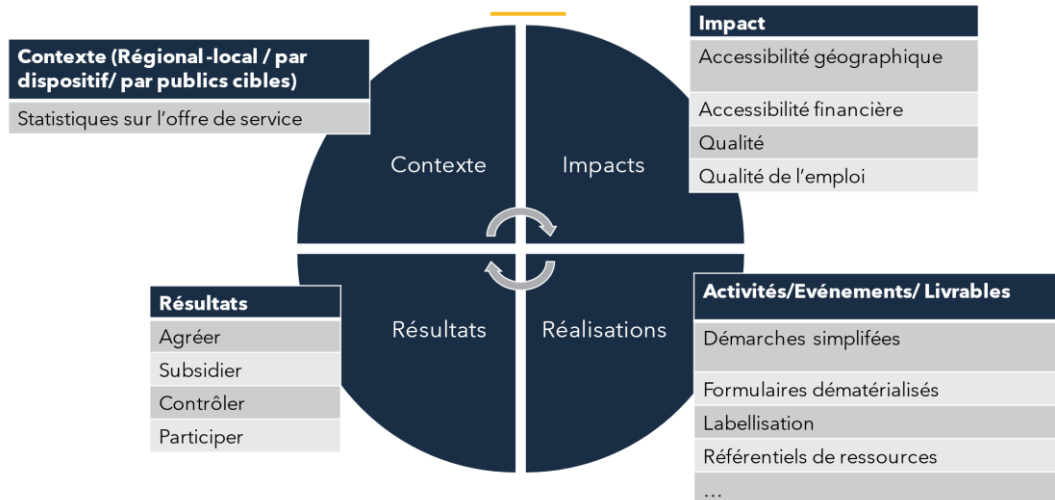
Ce chapitre présente une première ébauche des tableaux de bord des indicateurs. Il sera consolidé et enrichi lors de l'élaboration du plan d'entreprise.



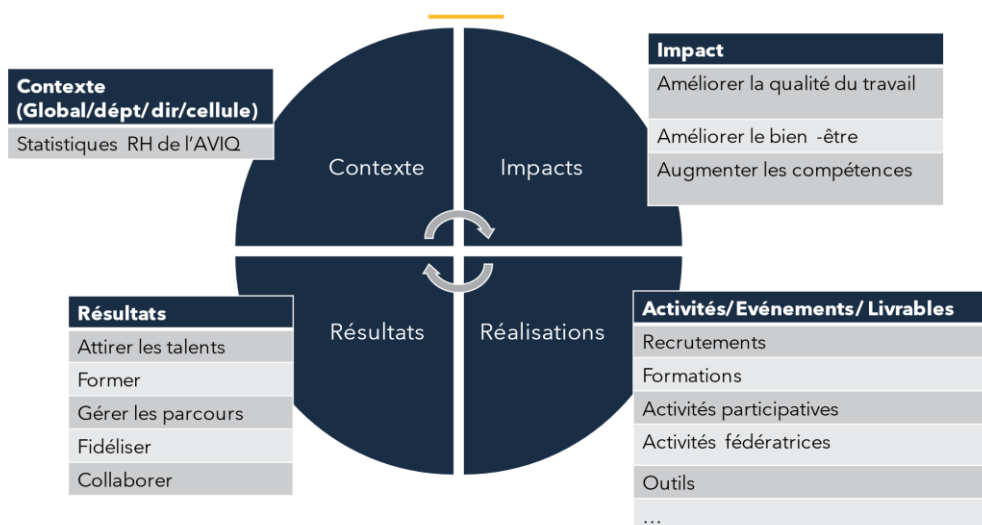
CITOYEN.NE.S



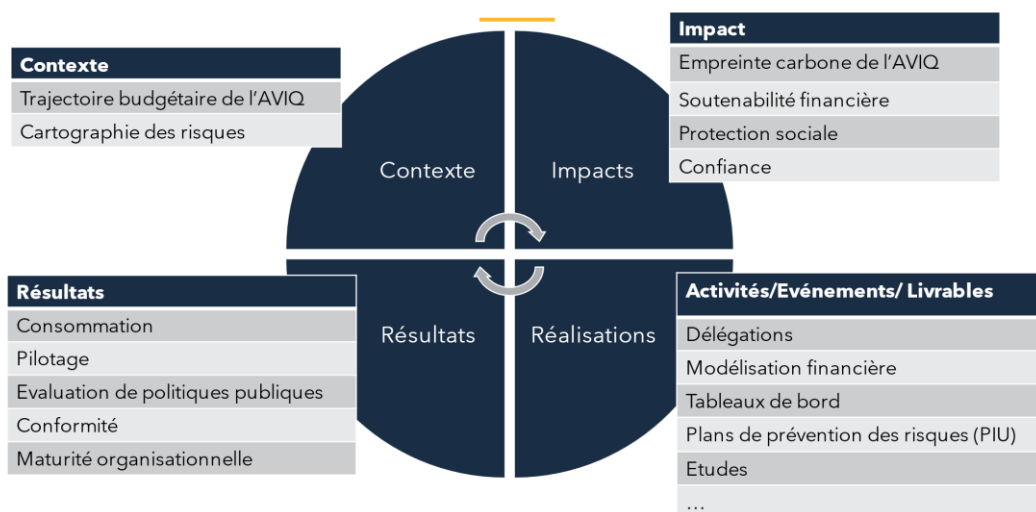
PARTENAIRES



ESPRIT AVIQ



ORGANISATION



Pour le Gouvernement wallon,

Christie MORREALE

Valérie DE BUE

Vice-Présidente du
Gouvernement, Ministre de
l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale et de
l'Economie sociale, de l'Egalité
des chances et des Droits des
Femmes

Ministre de la Fonction publique,
du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière.

Pour le Conseil général de l'AVIQ,

Fabienne WINCKEL

Muriel GERKENS

Présidente du Conseil général

Vice-Présidente du Conseil général

Pour le Comité de direction,

Françoise LANNOY

Anne-Françoise CANNELLA

Administratrice générale

Administratrice générale adjointe

ANNEXE 1 : PROJETS DE PLAN D'ENTREPRISE PRÉSENTÉS À TITRE ILLUSTRATIF DANS LE CONTRAT DE GESTION

**Accompagner chaque citoyen.ne dans son quotidien,
au départ de ses besoins, de ses aspirations et de son environnement**

Capter les besoins pour des réponses intégrées et adaptées

SWISS

Générer, analyser et diffuser des données de santé permettant de cerner l'état de santé de la population wallonne (lien avec W.all.in.health) - Production de tableaux de bord

Stratégie comportementale et culturelle (Behavior Cultural Insight)

Mettre en place une unité de connaissance comportementale et culturelle permettant d'explorer les facteurs structurels, contextuels et individuels qui influent sur les comportements liés à la santé des personnes, que ce soit dans leur vie quotidienne ou dans leur utilisation des services de santé

Carnet de vie digitalisé

PRW279 - Digitaliser intégralement le dossier de santé de manière structurée et intégrée : signalétique du citoyen, Vacciwal, allergies/antécédents, fiche de liaison gériatrique, SUMEHR bis, trajet de soins maladies chroniques, dossier de soins en SM, prévention/dépistage des cancers, analyses sanguines, bactériologiques et autres examens, traitements en cours, agenda patient, ... (PRW 279, 280 et 282)

Outil d'évaluation de l'autonomie

Analyser les outils existants (BELRAI, KATZ, SMAF, ...) en vue de mettre en place un outil générique d'analyse des besoins et des demandes des usagers mais également de les articuler avec le projet de vie de ceux-ci

Plan d'accompagnement et de soins

Mettre en place un plan d'accompagnement et de soins, pluridisciplinaire, cohérent, articulé et partagé entre toutes les parties prenantes

Développer les compétences pour des choix éclairés

ABC des démarches citoyens

Construire un outil à destination des usagers qui leur permet de trouver facilement les aides dont ils ont besoin et les démarches à faire pour en bénéficier. L'objectif est également de partager cette base de données avec

	l'ensemble des sites publics et guichets régionaux et locaux
Chaque porte est la bonne	Construire des réseaux d'accueil, d'accompagnement et d'information, en exécution de la DPR, avec les bureaux régionaux de l'AVIQ et leurs partenaires de terrain (organismes assureurs, caisses d'allocations familiales, opérateurs, guichets de proximité, ...). Renforcer les collaborations et le partage de l'information afin que quelle que soit la porte d'entrée d'un système, une personne trouve l'information qui répond à ses besoins et peut prendre des décisions éclairées qui respectent sa liberté de choix
Peri-scope	Dématiser le processus d'inspection afin de constituer une base de données sur les opérateurs et les inspections réalisées sur le terrain en vue de fournir les données utiles à une analyse de risques mais également une publication grand public relative au respect des normes régionales
Référentiel des ressources autour de chez soi	Construire, dans le cadre du projet W.all.in.health, un outil mettant à disposition un répertoire des opérateurs de protection sociale wallons (Mon Aviq), leurs missions et activités, les événements, les campagnes, les actions afin de leur permettre d'identifier l'ensemble des ressources disponibles (santé, aide aux aînés, aux personnes en situation de handicap, ...) autour de chez eux
Impliquer les citoyen.ne.s dans les projets qui impactent leur vie	
Mesure de la satisfaction	Elaborer des outils (enquêtes, test, panels usagers, ...) afin d'évaluer de manière plus systématique et scientifique la satisfaction des usagers de l'AVIQ quant aux services qu'elle propose (démarches, informations, formations, gestion des plaintes, ...)
Plateforme participative citoyen.ne.s	Mettre en place une plateforme qui soutiendra et complètera les actions participatives de l'Agence notamment en permettant aux citoyen.ne.s de partager leur vécu, leur avis sur des thématiques ou encore de participer à des projets et actions

Automatiser le recours aux droits

Cadastre des allocations familiales

Élaboration d'une base de données centralisée des prestations et bénéficiaires d'allocations familiales et permettre/réguler les échanges de données

Non take-up streaming

Développer une méthodologie identifiant le non-recours aux droits dans l'ensemble des dispositifs de l'Agence

Plan accessibilité wallon 22-24

Coconstruire une société plus accessible : réduire les obstacles à la participation, améliorer l'accès des personnes à mobilité réduite (espace, transports, information et communication). Le plan couvre l'action sociale et la santé, le logement, l'aménagement du territoire et la mobilité, le numérique, la vie culturelle et le tourisme, la vie récréative et la pratique du sport, l'accès aux parcs et sites naturels ou encore au patrimoine

Aide matérielle amplifiée

Permettre l'aide matérielle simplifiée, préventive/évolutive (et automatique). Ce projet comprend également l'intégration dans la réglementation de l'aide matérielle au-delà de 65 ans

Bâtir une transformation digitale inclusive

Dossier individuel usager (only once)

Construire un dossier unique des usagers de l'Agence en vue d'accélérer et simplifier le traitement des dossiers (only once) par le partage des données, l'utilisation des sources authentiques

Comité des utilisateurs

Veiller à la pertinence et l'accessibilité des outils numériques de l'AVIQ : groupes de travail composés d'utilisateurs afin qu'ils testent les outils tout au long du processus de construction (panel de citoyen.ne.s, agents, partenaires, ...)

Aidants numériques

Accompagner les usagers dans leur maîtrise des équipements et outils numériques en veillant à tendre vers l'autonomie des usages du numérique

Fédérer les partenaires pour construire des réponses intégrées et innovantes

Simplifier les échanges administratifs

Principe de confiance

Appliquer le principe de confiance à l'ensemble des dispositifs de subventionnement de financement - screening à réaliser pour identifier les dispositifs qui pourraient intégrer le principe

**Référentiel unique des opérateurs -
Mon AVIQ**

Construire et partager un référentiel unique des opérateurs agréés et/ou subventionnés par l'AVIQ leur donnant accès à un guichet transactionnel unique leur permettant de déposer leur demande, de suivre leur traitement et d'échanger avec l'Agence (signalétique, formulaires et suivi des dossiers)

**Dématérialisation des démarches -
Mon AVIQ**

Dématérialiser les démarches et transactions avec l'Agence de bout en bout : de la demande (formulaire) à la réponse apportée (agrément, titre de fonctionnement, subvention, inspection, rapport d'activité, ...)

Mobiliser les partenaires dans l'évaluation
des politiques publiques et les projets de réforme

**Plateforme participative
opérateurs**

Construire une dynamique participative avec les opérateurs partenaires de l'AVIQ, sur la base de l'évaluation de la dynamique Proxisanté : ateliers, tables rondes, enquêtes, ... La plateforme soutiendra et complètera les actions participatives

Fonction consultative

Organiser la fonction consultative des comités de branche et du conseil général

Centrer le cadre sur l'objectif commun, assoupli et permettant l'expérimentation

**Stratégie de revalidation
fonctionnelle en Wallonie**

Définir une stratégie wallonne pour le secteur de la revalidation fonctionnelle centrée sur l'aide à un public cible dans sa revalidation, l'assurance de soins les plus adéquats et afin de permettre d'acquiescer ou retrouver une autonomie permettant de retrouver ou trouver une place dans la société

**Continuum de soins
de santé mentale**

Poursuivre le développement d'un continuum de soins en favorisant la prise en charge des soins de santé mentale dans la cité au sein de toutes les tranches d'âge et tous les milieux de vie de la population en Wallonie (PRW275)

**Initiatives alternatives
à l'hébergement collectif**

Exploiter les expériences de terrain, les pratiques de réseau alliant accompagnement des personnes et accompagnement des membres de la société ainsi que les publications de travaux de recherche réalisés par les services d'accompagnement de Wallonie en collaboration avec des services d'études

**Révision des normes en maisons de
repos et maisons de repos et soins**

Améliorer la qualité de l'accueil et de l'hébergement en prenant en compte l'évolution du secteur et des leçons tirées de la crise Covid.

Informier mieux les résidents et leur entourage par la mise en place d'un dispositif de publicité sur le fonctionnement des établissements.

Organiser la gestion des plaintes en première ligne au sein des établissements.

Réforme de l'accueil et hébergement - désinstitutionnalisation

Évaluer, par un audit en matière de bonne gouvernance des établissements accueillant des personnes en situation de handicap afin de formuler des propositions de pistes d'améliorations

Responsabilisation des intermédiaires de paiement

Financer les frais de gestion des intermédiaires de paiement en tenant compte d'un critère quantitatif lié à la charge de travail et d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations

Déployer les réseaux

Décret Proxisanté

Créer des réseaux d'accompagnement et de soins via notamment l'élaboration d'une gouvernance et d'un maillage territorial et soutenir les acteurs locaux dans l'implémentation de leur écosystème - PRW273

Case managers ou coordinateurs intersectoriels

Développer et renforcer le rôle de coordinateurs intersectoriels au sein de la première ligne d'aide et de soins dont la fonction principale est de définir précisément et conjointement l'objectif du suivi, puis d'accompagner la personne tout au long du circuit d'intervention

Chaque porte est la bonne

Voir supra

Digitaliser et partager l'information

Mon Aviq (front office transactionnel opérateurs)

Construire un guichet transactionnel unique permettant aux opérateurs de déposer leur demande, de suivre leur traitement et d'échanger avec l'Agence (signalétique, formulaires et suivi des dossiers)

ABC des démarches partenaires

Construire un outil à destination des opérateurs qui leur permet de trouver facilement les aides dont ils ont besoin et les démarches à faire pour en bénéficier (agrément, titre de fonctionnement, subvention, ...). L'objectif est également de partager cette base de données avec l'ensemble des sites publics et guichets régionaux et locaux

W.all.in.health

Observer, cartographier les ressources et offrir un outil de suivi administratif aux opérateurs. L'outil sera développé dans un premier temps en vue de soutenir et renforcer les actions wallonnes en promotion de la santé et en prévention - PRW281

Grandir en tant qu'organisation apprenante et responsable

Optimiser nos activités

OPTIQ (optimisation des processus et transparence de l'information pour la qualité)

Mettre en place un système de contrôle interne par la réalisation d'un référentiel des missions et activités de l'agence, une cartographie des macro-processus et processus, leur description et documentation et enfin, leur optimisation (simplification, mesures de maîtrises, amélioration continue)

Outil de gestion prévisionnelle et dynamique des effectifs et des compétences de l'AVIQ

Anticiper les besoins de ressources humaines et de compétences de l'Agence sur la base des missions et activités actuelles et futures, adapter - à court et moyen terme - les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la nouvelle vision stratégique et des modifications de l'environnement économique, technologique, social et juridique dans lequel l'Agence réalise ses activités

Outils de monitoring des dépenses et des recettes

Améliorer le reporting sur l'ensemble des dépenses et de recettes de l'Agence, en tant qu'outils d'aide à la décision politique : évolutions, perspectives, enjeux financiers et budgétaires, analyse par politique/dispositif, liaison entre les besoins et les propositions, ...

Trajectoire budgétaire

Construire une méthodologie et une maquette budgétaire intégrant les paramètres d'évolution des dépenses et des recettes mais également de poser des hypothèses d'évolution en vue de proposer une trajectoire budgétaire à court et moyen terme

Tableaux de bord du contrat

Construire les tableaux de bord du contrat : le premier reprenant l'ensemble des indicateurs relatifs aux besoins, à l'offre de services, aux missions et activités de l'Agence ainsi qu'aux politiques publiques et le second reprenant les indicateurs d'impacts et de résultats en lien avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l'Agence ainsi que les ressources et réalisations consacrées aux projets et innovations du plan d'entreprise

Délégation

Permettre aux instances de déterminer les buts et objectifs de l'Agence, d'adopter et de superviser les plans d'action et d'allouer les ressources, laissant au comité de direction et à l'administration la gestion courante et opérationnelle de ses missions et activités

Anticiper et gérer les risques

Plan interne d'urgence - risques sécurité et santé

Identifier et cartographier les risques en matière de sécurité et de santé (incendie, accident, fuite de gaz, ...) et définir les plans d'actions y afférents

**Plan interne d'urgence -
risques techniques**

Identifier et cartographier les risques techniques (systèmes d'information et d'exploitation menacés) et définir les plans d'actions y afférents

**Plan interne d'urgence -
risques organisationnels**

Identifier et cartographier les risques organisationnels (fraude, perte financière, conflit social, crise externe...) et définir les plans d'actions y afférents

**Plan interne d'urgence -
fermeture / crise au sein
d'un service d'hébergement**

Identifier et cartographier les risques au sein des secteurs (plaintes, normes) et définir les plans d'actions y afférents notamment en termes de concertation avec les autorités locales

**Gestion des risques
épidémiques**

Organiser la gestion des risques épidémiques au sein de l'AVIQ (veille sanitaire, vaccination, testing, stratégies de prévention, protocoles sanitaires, logistiques, gouvernance, ...), structurer la collaboration entre l'ensemble des services, la chaîne de décision, la communication de crise et clarifier et articuler l'action de l'AVIQ aux niveaux fédéral, régional et local

Évaluer les politiques publiques

**Étude prospective sur les politiques
publiques en matière de lutte contre la
pauvreté infantile à l'horizon 2050**

Identifier quels sont les futurs possibles pour les politiques de lutte contre la pauvreté infantile à l'horizon 2050

**Inventaire et priorisation des
dispositifs**

Inventorier et prioriser les outils de politiques publiques gérés par l'Agence, identifier les objectifs politiques poursuivis et les paramètres d'évolution et d'évaluation de ces dispositifs. Permettre ensuite une priorisation des évaluations de politiques publiques à réaliser

Cartographie des parties prenantes

Identifier les parties prenantes, comprendre l'environnement et impliquer toutes les parties prenantes dans l'évaluation et la définition des politiques à court, moyen et long termes

Piloter la transformation digitale inclusive de l'agence

**Feuille de route pour une
transformation digitale inclusive**

Aboutir à une organisation "zéro papier" par la simplification des processus, la construction d'un nouveau guichet pour les usagers, le déploiement d'un back office afin de permettre l'échange et le partage des dossiers entre l'ensemble des services. Le projet sera inclusif par sa dynamique de soutien et d'accompagnement de tous dans le numérique et le maintien d'un accueil et d'un accompagnement physique, interpersonnel des usagers

Feuille de route de cybersécurité

Définir et à prioriser les actions à mener par l'Agence en matière de Cybersécurité

Gouvernance des données

Garantir la qualité de l'information (exactitude, actualité, intégrité, cohérence, exhaustivité, fiabilité, sécurité des données), la disponibilité des données, l'éthique dans l'utilisation et l'exploitation des données, la conformité de gestion des données notamment au regard du RGPD et enfin, la sécurité des échanges et des entrepôts de données

Incarnar l'esprit AVIQ par l'expertise, la bienveillance, l'engagement et l'autogouvernance

Renforcer la culture collaborative

Nouveau cadre de l'Agence

Doter l'Agence d'une structure managériale (au travers d'un AGW) lui permettant d'accomplir ses missions et enjeux, en renforçant la transversalité, la capacité de l'Agence à gérer les risques et crises et en organisant les nouvelles missions stratégiques et consultatives des instances

Communautés de pratiques

Mettre en place des communautés dépassant la logique hiérarchique et décloisonnant les services, permettant l'intelligence collective, la transversalité, la recherche de solutions adaptées et efficaces et l'innovation (pôle de médecins, plateforme de santé mentale, gestion de projet, process and risk manager, marchés publics, correspondants budgétaires, correspondants RH, ...)

Espaces de travail partagés

Mettre à disposition du personnel de l'AVIQ et des agents des services publics wallons, des espaces de travail décentralisés, alternative au travail à domicile mais également, permettant une articulation plus souple des activités (réunions, visites de terrains, ...) et déplacements des agents

Développer les compétences

Stratégie de formation

Entrer dans un parcours de formation obligatoire dès l'entrée en fonction, élaborer un trajet de formation tout au long de sa carrière, former les managers

Valorisation et certification des compétences et expériences

Valoriser certaines fonctions et métiers en pénurie par la prise en compte de l'expérience et des compétences

Branding

Créer la marque "AVIQ" qui permettra d'accroître sa notoriété et son image auprès du public (citoyens, partenaires, etc.)

Coconstruire un environnement de travail stimulant

Stratégie immobilière AVIQ

Développer une nouvelle politique immobilière durable et responsable : à Charleroi, en regroupant l'ensemble de ses services sur un site unique et dans les provinces, en privilégiant des investissements au cœur des villes, plus accessibles, plus conviviaux pour l'accueil des publics et des partenaires (espace de coworking, réunions, guichets) et en déployant notre présence sur tout le territoire afin de garantir une présence physique de proximité (antennes)

Feuille de route « Objectifs de développement durable »

Élaborer la stratégie en matière de développement durable de l'AVIQ sous la forme d'une feuille de route basée sur un diagnostic de l'impact de l'organisation sur chacun des 17 Objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies

Travail hybride

Travailler de manière efficace et libre tant à domicile qu'au sein des infrastructures de l'AVIQ, favoriser et intensifier la collaboration

Améliorer le bien-être au travail

Plan global et des plans annuels de bien-être au travail

Construire, pour l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, un environnement de travail sain, sécurisant et stimulant au travers de l'adoption d'un plan global de bien-être au travail et de plan d'actions annuels

Accompagnement au changement

Assurer et implémenter une méthodologie du changement pour accompagner les équipes en place chargées des projets de changement

Plan AVIQ en pleine santé

Mettre en œuvre un plan d'actions spécifique pour promouvoir la prévention de la santé au sein de son personnel

Droit à la déconnexion

Définir un véritable droit mais aussi devoir à la déconnexion et de sensibiliser l'ensemble du personnel à ces impératifs

Digitaliser et partager l'information

Nouvel intranet - intégration dans le cloud

Construire l'intranet à partir des nouveaux outils collaboratifs (365) et revoir sa gouvernance : articulation avec les outils collaboratifs (teams - Delfe - ...) - gouvernance (alimentation) - suivi et évolution de l'outil

Référentiel des ressources de l'AVIQ

Construire un référentiel sur l'ensemble des ressources de l'Agence (son organisation, qui fait quoi, ...)

OPTIMUS

Construire un back-office (outil de gestion et de suivi des dossiers) soutenant l'ensemble des activités d'agrément, de contrôle, de subventionnement... de l'administration en faveur de ses usagers

E-Délibération

Déployer un outil de gestion des délibérations de l'ensemble des instances de l'Agence (CG, CB, CP, CMFB, CIC, COMDIR, ...) gérant les invitations, présences, ordre du jour, documents, décisions, ...